CUENTA PÚBLICA 2026 MINISTERIO DE SALUD

I. Definiciones Estratégicas Ministeriales

1. Misión del Ministerio

Cuidar la salud de la población, garantizando el acceso equitativo a acciones de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Asimismo, proteger frente a los riesgos financieros asociados a las necesidades de salud, responder a las expectativas de la población con mayor calidad y oportunidad en la atención, y promover un trato digno tanto para usuarios como para prestadores, fortaleciendo además las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.

2. Objetivos Estratégicos del Ministerio

- Garantizar el cumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud (GES), con énfasis en patologías oncológicas, mediante la gestión activa de garantías incumplidas en la red pública y la asignación automática de segundo prestador al 2030.

- Reducir los tiempos de espera quirúrgicos y de consulta de nueva especialidad en la red asistencial, mediante el fortalecimiento de la APS, integración complementaria de la capacidad pública y privada, programación quirúrgica eficiente y la gestión activa de listas de espera.

- Mejorar la capacidad de dirección estratégica de los Servicios de Salud y Hospitales Públicos, aumentando los mecanismos de control y planificación, promoviendo la eficiencia y disciplina en el uso de los recursos públicos.

- Incrementar el cumplimiento de estándares de gestión clínica y sanitaria, mediante la instalación de subdirecciones médicas funcionales, la provisión de cargos críticos de Alta Dirección Pública, la implementación de sistemas de control y rendición de cuentas en el uso de recursos y calidad de la atención.

- Optimizar la distribución territorial de la infraestructura en salud desarrollando una estrategia de inversión, con enfoque de equidad y focalización.

- Mejorar el funcionamiento de la red asistencial en salud mental, enfermedades crónicas y cuidados paliativos, a través del acceso oportuno y la continuidad efectiva de cuidados a lo largo del curso de vida, que permitan obtener mejores resultados sanitarios.

- Incrementar la resolutividad de la Atención Primaria de Salud, su articulación con el nivel secundario y su rol en prevención y promoción de la salud, redefiniéndola como el eje estructural del sistema sanitario.

- Optimizar la operación de la red, implementando la interoperabilidad de los sistemas de información en la salud pública, utilizando nuevas tecnologías, gestión de datos estructurados, con criterios de calidad, trazabilidad y oportunidad.

- Garantizar el abastecimiento oportuno a medicamentos y otros recursos de salud, mediante una gestión eficiente de recursos, generando ahorros para la población y el Estado.

- Expandir la telemedicina y los servicios de salud digital en APS y los hospitales, reduciendo brechas territoriales en el acceso a especialidades y mejorando la continuidad de cuidados.

- Contribuir al perfeccionamiento del sistema de salud mediante acciones preventivas y correctivas que incrementen su eficiencia y eficacia y garanticen la protección oportuna y equitativa de los derechos en salud de las personas.

- Posicionar el rol de autoridad científico-técnica y sanitaria de referencia nacional, mediante el fortalecimiento de sus funciones regulatorias, de vigilancia, fiscalización, investigación e innovación, incorporando nuevas tecnologías y asegurando altos estándares de calidad.

- Fortalecer el rol de seguro público del Fondo Nacional de Salud, que otorgue cobertura, oportunidad y financiamiento en salud a sus personas beneficiarias, asegurando el buen uso de los recursos, con eficiencia, equidad y calidad técnica, para contribuir a mejorar los resultados en salud.

3. Datos que permitan dimensionar el estado de situación del sector, incluyendo principales desafíos pendientes.

a. Estrategia Nacional de Salud

La Estrategia Nacional de Salud se enmarca en la función rectora del Ministerio de Salud y constituye el principal instrumento de planificación que orienta el quehacer del sector para el logro de los Objetivos Sanitarios. Estos fueron establecidos para el período 2021–2030 mediante la Resolución Exenta N°831 de junio de 2024, y corresponden a: mejorar la salud y bienestar de la población; disminuir las inequidades en salud; y asegurar la calidad de la atención en salud. Para avanzar en estos, se definieron nueve Objetivos Estratégicos que abordan 52 temas, cada uno con sus respectivos indicadores.

En la evaluación de mitad de período, correspondiente a estadísticas vitales preliminares 2023 y 2024, en la que se analizaron sólo los indicadores de impacto se observa que un 34,4 por ciento cumple la meta definida al 2030; un 24,6 por ciento se encuentra en estado de retroceso; un 23 por ciento presenta algún nivel de avance; un 16,4 por ciento no ha sido posible evaluar; y un uno 1,6 por ciento no reporta avances, de un total de 61 indicadores.

Se han alcanzado avances relevantes y un tercio de los indicadores de impacto han sido cumplidos, persisten desafíos importantes en aquellos que, aun mostrando progreso, no logran alcanzar los objetivos estratégicos definidos. A ello se suma el grupo de indicadores en retroceso, que representa una preocupación mayor y exige fortalecer la gestión, incorporando innovación y abordajes intersectoriales que permitan enfrentar la complejidad de los problemas sanitarios y sus determinantes sociales.

Es importante destacar que, si bien la Estrategia fue diseñada para regir entre los años 2021 y 2030, los objetivos fueron fijados recién en junio de 2024, lo que limita el período de influencia de ésta y hace que la evaluación de mitad de período de 2025 refleje en la práctica menos de dos años en que la estrategia estuvo operativa. Esto, sumado a algunos indicadores de impacto no calculables, limitaciones en la disponibilidad y oportunidad de la información (cinco indicadores calculados con datos preliminares del 2022 en la evaluación de mitad de período), y 143 indicadores de proceso que exigen una gran carga administrativa asociada a escaso valor sanitario, hace necesaria una reestructuración de la Estrategia que se realizará este año para lograr los objetivos sanitarios de cara al 2030.

En síntesis, avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos al 2030 requiere una reestructuración de los indicadores con mirada estratégica; avanzar en el desarrollo de sistemas de información robustos; fortalecer la coordinación intra e intersectorial; y focalizar los esfuerzos en las áreas de mayor rezago, con un enfoque centrado en los determinantes sociales de la salud.

b. Crisis epidemiológica del cáncer

El cáncer es la primera causa de muerte en el país, superando a las enfermedades cardiovasculares, por lo tanto, se ha convertido en el principal problema de salud pública en Chile. El cáncer provoca aproximadamente 30 mil fallecimientos anuales, con 60 mil nuevos casos diagnosticados cada año. Además, existen brechas de

desigualdad en el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno. Genera una alta carga económica para los sistemas de salud y afecta principalmente a las familias chilenas que presentan mayores desigualdades económicas. Para combatir estos efectos, el Plan Nacional de Cáncer en Chile, es considerado un compromiso de Estado y una prioridad política de los sucesivos gobiernos. La Ley Nacional del Cáncer, promulgada en el año 2020, mandata la elaboración del Plan Nacional de Cáncer.

El sistema público de salud actualmente enfrenta un escenario de alta presión asistencial, marcado por un aumento sostenido de la demanda y por limitaciones en su capacidad de respuesta. A diciembre de 2025 se registran 78 mil 594 Garantías Explícitas en Salud (GES) retrasadas (oncológicas y no oncológicas), que afectan a 76 mil 719 personas, con una mediana de espera de 65 días y un promedio de 130 días. Estos retrasos se concentran principalmente en el nivel terciario de atención y en beneficiarios del Fonasa, lo que da cuenta de una brecha relevante entre la demanda por prestaciones y la capacidad efectiva del sistema para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente.

En este contexto de alta demanda asistencial, el país enfrenta una crisis epidemiológica del cáncer, evidenciada en el aumento sostenido de la incidencia de distintos tipos, como cáncer de mama, pulmón, próstata, colon, recto, vía biliar y vejiga. Esta situación ha incrementado la demanda por atenciones oncológicas, tensionando la Red Asistencial.

Las garantías GES retrasadas en cáncer han mostrado un aumento sostenido, pasando de catorce mil 782 casos en el tercer trimestre de 2025 a 18 mil 123 en el cuarto trimestre del mismo año, lo que equivale a un 22,6 por ciento más. A inicios de 2026, esta tendencia continúa al alza, alcanzando un 8,2 por ciento adicional al mes de febrero, lo que representó un 24,1 por ciento del total país, concentrándose en Cáncer Colorrectal, Cáncer Cervicouterino, y Cáncer de Mama, los que corresponden respectivamente al 27,3 por ciento, 24,8 por ciento y 19,4 por ciento, de retrasos en esta etapa.

A lo anterior, se suman seis mil 309 registros en listas de espera No GES correspondientes a consultas de nueva especialidad en áreas oncológicas, lo que refleja una demanda adicional fuera del régimen de garantías explícitas. Estos antecedentes evidencian retrasos relevantes tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del cáncer, factores que inciden directamente en la evolución de la enfermedad y en las posibilidades de sobrevida de los pacientes.

En síntesis, el aumento en la incidencia del cáncer, junto con el crecimiento de los retrasos en garantías GES y la acumulación de listas de espera No GES en el ámbito oncológico, configura un riesgo sanitario significativo para la población. Si bien en los últimos años se han implementado diversas estrategias para abordar esta situación, la magnitud del problema y la presión sobre la red asistencial hacen necesario reforzar las acciones orientadas a mejorar la oportunidad de atención y la continuidad de los cuidados.

En este escenario, los principales desafíos se relacionan con fortalecer la capacidad diagnóstica y terapéutica de la red asistencial, especialmente en el nivel terciario; mejorar la gestión y priorización de las listas de espera, tanto GES como No GES, y avanzar en mecanismos que permitan ampliar la oferta de prestaciones, a través de una mejor gestión de los recintos públicos de salud, integración con los prestadores privados y énfasis en la equidad territorial en el acceso a terapias. De igual manera, resulta fundamental optimizar el uso de los recursos disponibles y reforzar las estrategias de detección precoz y continuidad de cuidados, con el propósito de reducir los tiempos de espera y mejorar los resultados en salud de la población.

c. Tiempos de espera

- Lista de espera quirúrgica

En el periodo de febrero 2025 a febrero 2026 los registros asociados a lista de espera quirúrgica No GES aumentaron en 8,5 por ciento. Asimismo, el promedio de días de espera tuvo una disminución del 8,6 por ciento, pasando de un promedio de 421 a 385 días, manteniéndose el tiempo promedio de espera para cirugías por sobre

el año cronológico. Efectivamente, fue recién en octubre de 2025 que se alcanzó nuevamente la mediana de días de espera previa a la pandemia, con 254 días; a febrero de 2026 ésta es de 257 días. Esto implica un riesgo para la salud de la población, además de constituir una causa de angustia para las personas y sus familias, por lo que se deben tomar medidas concretas con sentido de urgencia para mejorar la oportunidad de atención.

La demanda se concentra principalmente en las especialidades de traumatología, cirugía digestiva, dermatología y odontología, que juntas acumulan el 56,9 por ciento de los registros totales. A nivel territorial, el 52,3 por ciento del volumen nacional de demanda pendiente se focaliza en regiones y servicios específicos, destacando Maule, O'Higgins, Araucanía Sur, Metropolitana Sur Oriente, Coquimbo, Biobío, Concepción, Ñuble y Viña del Mar-Quillota.

En términos generales, el aumento sostenido de la demanda, junto con la persistencia de tiempos de espera elevados y su concentración en determinadas especialidades y territorios, configura un escenario de presión estructural sobre la red asistencial. Si bien se han implementado medidas para mejorar la productividad quirúrgica y la gestión de listas de espera, la magnitud del problema exige profundizar estrategias orientadas a fortalecer la programación quirúrgica y la gestión activa de la demanda, optimizar el uso de pabellones y equipos clínicos, e incrementar la articulación entre niveles de atención y con prestadores externos. Asimismo, resulta clave avanzar en mecanismos que permitan ampliar la oferta quirúrgica, reducir brechas territoriales y priorizar oportunamente a los pacientes según criterios clínicos, con el propósito de disminuir los tiempos de espera y mejorar los resultados en salud de la población.

- Lista de espera consulta nueva especialidad

Por otra parte, en lo que respecta a la lista de espera No GES por consulta nueva especialidad médica y odontológica, en el periodo señalado los registros disminuyeron en un 7,9 por ciento, de igual forma el promedio disminuyó de 354 días a 329, con un fuerte componente de desigualdad en el acceso: si bien la mediana de días de espera disminuyó de 260 a 233 días entre febrero de 2025 y febrero de 2026, el percentil 75 de días de espera a febrero de 2026 es de 457 días. Respecto a la demanda, el 50,5 por ciento se concentra en siete especialidades: Oftalmología, Otorrinolaringología, Ginecología, Rehabilitación Oral Removible, Traumatología y Ortopedia, Cirugía General, y Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilo Facial.

A nivel territorial el 54,1 por ciento de la demanda pendiente se concentra en los siguientes servicios de salud: Araucanía Sur, Metropolitano Sur, Metropolitano Occidente, Metropolitano Sur Oriente, Coquimbo, Viña del Mar, Del Maule, Metropolitano Norte y Metropolitano Central.

- Garantías explícitas en salud retrasadas

El total de garantías se incrementó en el año 2025, respecto al año 2024, en un 9,1 por ciento, lo que significa 455 mil 263 garantías más. A febrero 2026 se registra un total de 82 mil 881 garantías retrasadas, con un promedio de días de retraso de 127 días. Al comparar con el mismo corte del año 2025, hay un aumento en el total de garantías retrasadas de dos mil 419 equivalente al tres por ciento. Respecto a los Servicios de Salud con mayor número de garantías retrasadas, a febrero 2026 estos son el Servicio de Salud O'Higgins con el 9,7 por ciento del total de garantías retrasadas de país, el Servicio de Salud Araucanía Sur con 8,8 por ciento del total y el Servicio de Salud Metropolitano Norte, que representa el 8,3 por ciento del total país.

Tabla N° 1: Diez Patologías con mayor número de garantías retrasadas acumuladas a febrero 2026

Problemas de Salud	Retrasadas Acumuladas	% sobre el total de garantías retrasadas
11-Cataratas	10.989	13,26
07-Diabetes mellitus t2	10.934	13,19
29-Vicios de refracción	7.215	8,71
56-Hipoacusia adulto	6.146	7,42
31-Retinopatía diabética	6.116	7,38
70-Cáncer colorrectal	5.454	6,58
03-Cáncer cervicouterino	4.952	5,97
08-Cáncer de mama	3.876	4,68
26-Colecistectomía preventiva	2.791	3,37
36-Ayudas técnicas	2.243	2,71

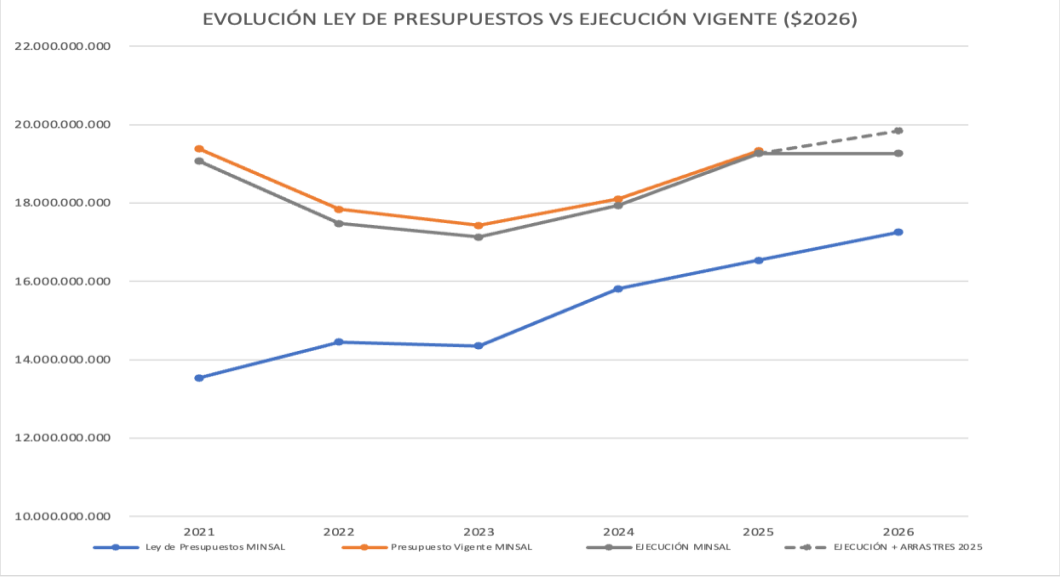
Fuente: División de Gestión de la Red Asistencial, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud.

Estas diez patologías representan el 73,3 por ciento del total de garantías retrasadas acumuladas al período.

d. Situación Financiera

El sistema público de salud enfrenta en el año 2026 una tensión financiera de carácter estructural, no coyuntural. La brecha entre la Ley de Presupuestos y el gasto efectivo de los Servicios de Salud ha sido una constante en la última década, pero ha alcanzado niveles que requieren acción legislativa coordinada, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N°1: Evolución Ley de Presupuestos en relación con la ejecución vigente



Fuente: División de Presupuestos, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud.

En el gasto operacional (bienes y servicios de consumo) de los Servicios de Salud coexisten dos tipos de deuda con naturaleza y tratamiento contable diferente. Existe la deuda flotante, que por definición es reconocida en los

sistemas contables y financieros; ésta se encuentra formalmente devengada. El monto al cual asciende la deuda flotante es de 240 mil 599 millones de pesos. Su situación actual al cierre del año 2025 es que se encuentra dentro del sistema contable, pero pendiente de pago.

Por otra parte, existe una deuda de arrastre, asociada a bienes y servicios sin marco presupuestario vigente, que se encuentra fuera de la contabilidad formal. Dicha deuda alcanza 565 mil millones de pesos. Esta no está devengada oficialmente al cierre del año 2025 y se está incorporando actualmente al gasto 2026.

Esta brecha estructural del financiamiento en salud ha generado un efecto crítico a nivel presupuestario, principalmente visible en el periodo enero-febrero 2026 dado que el devengo acumulado a febrero alcanza 919 mil 805 millones de pesos, equivalente a 3,1 meses del presupuesto mensual asignado para el año completo, estimado en 297 mil millones de pesos. Este gasto de recursos en los primeros meses del año, correspondiente al devengo de la deuda de arrastre del año anterior, se suma al dinero que todavía no es incorporado al sistema contable: quedan pendientes 239 mil millones de pesos de arrastre correspondientes a 2025 por incorporar al gasto recurrente del año 2026

El comportamiento histórico del presupuesto ha mostrado un aumento sostenido en el periodo señalado acorde a cifras de la DIPRES, asociadas al subtítulo 22 de los Servicios de Salud. Como es posible observar en el gráfico N°2 en el año 2023, se produce la primera deuda de arrastre al cerrarse el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado por sobre el presupuesto aprobado.

Tabla N° 2: Comportamiento histórico devengo enero – febrero (MM$ reales 2026)

2022	2023	2024	2025	2026
450.854	501.961	670.513	889.544	919.805

Fuente: División de Presupuestos, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud.

En este contexto, el principal desafío radica en avanzar hacia un modelo de financiamiento más realista y sostenible, que permita alinear de manera efectiva la planificación presupuestaria con la demanda asistencial. Asimismo, se requiere fortalecer los mecanismos de control, monitoreo y gestión del gasto, con foco en la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia en la ejecución y la contención de nuevas deudas. Todo ello resulta fundamental para resguardar la continuidad operativa de la Red Asistencial y asegurar una respuesta oportuna y de calidad a las necesidades de salud de la población, bajo criterios de responsabilidad fiscal.

e. Ausencia de planificación en la cartera de inversiones.

La red cuenta actualmente con mil 356 iniciativas de inversión, cuyo estado y fase en el ciclo de vida de cada proyecto se detallan en la tabla técnica adjunta. El elevado volumen de proyectos de arrastre que incluye 198 en ejecución y 228 en diseño representa un desafío de gestión de gran magnitud.

Tabla N° 3: Cartera de proyectos vigentes

Estado Proyecto	APS	Pre Hosp.	Hospitales	Obras Hosp.	Salud Mental	Obras Cáncer	Otros	Conservación	Total
Idea	209	25	36	109	95	3	17	1	495
Estudio	122	62	47	30	22	12	3	111	409
Diseño	132	2	14	25	16	9	3	35	236
Ejecución	98	1	31	18	10	7	4	23	192
En Marcha Blanca	15	0	3	1	0	4	2	1	26
Total General	**576**	**90**	**131**	**183**	**143**	**35**	**29**	**171**	**1.358**

Fuente: División de Inversiones, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud.

Estos mil 358 proyectos en cartera implican una alta presión sobre el presupuesto sectorial, ya que una proporción significativa de los recursos se encuentra comprometida en iniciativas en desarrollo, reduciendo considerablemente el margen disponible para la incorporación de nuevos proyectos y frustrando las expectativas de la población y sus representantes, a quienes se les acogieron sus requerimientos y se les dio la esperanza de que se materializarían.

Esta concentración de iniciativas refleja la ausencia de un plan de inversiones formalizado mediante resolución. Ante este complejo escenario de arrastre, agravado por las actuales restricciones presupuestarias, resulta imperativo priorizar la cartera de proyectos nuevos con el objetivo de garantizar su viabilidad financiera y factibilidad operativa desde su origen, además de asegurar la continuidad de los proyectos de arrastre mediante estrategias específicas que protejan la inversión en las fases críticas de ejecución.

Cabe destacar que el costo total de la cartera de inversiones actual asciende a un monto estimado de 19 billones de pesos, con una magnitud que equivale a 36 años presupuestarios plenos en vista de la disponibilidad actual del Sector bajo el subtítulo 31 de la Ley de Presupuestos 2025.

f. Disciplina del Sector

- Sumarios Licencias médicas

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales de control, la Contraloría General de la República (CGR), ha emitido diversos informes logrando identificar a marzo del año 2026 un total de 28 mil 990 casos en el sector salud. Por “caso” se debe entender como cada evento asociado al uso inadecuado o eventual emisión fraudulenta de una licencia médica. Por ende, una persona o un funcionario puede registrar más de un caso de uso irregular de licencias médicas.

Estos 28 mil 990 casos, se traducen en quince mil 29 funcionarios objeto de ser investigados, trece mil 929 funcionarios deben ser investigados por sumario administrativo, de este conjunto trece mil 42 funcionarios se encuentran con procesos sumariales instruidos en el marco de las directrices impartidas por la Contraloría. Por otra parte, solo el 3,11 por ciento del total a ser investigado, lo que equivale a 433 funcionarios, registran su proceso cerrado, con 777 funcionarios cuyos procesos fueron enviados a la Contraloría para toma de razón.

En el ámbito del sector salud, el uso inadecuado de licencias médicas genera efectos directos sobre la continuidad de la atención asistencial, incrementa la sobrecarga de los equipos de trabajo, tensiona la organización de los turnos, requiere recursos adicionales para contratar reemplazos y afecta negativamente la calidad y oportunidad de la atención otorgada a la población.

En términos de gestión, estas cifras muestran un avance en la instrucción de sumarios, pero también evidencian una brecha relevante en la etapa de resolución y cierre efectivo de los procedimientos, que constituye hoy el principal desafío del sector en esta materia, con el objeto de asegurar certeza jurídica, eficacia disciplinaria y el adecuado funcionamiento de la red asistencial.

- Alta Dirección Pública (ADP)

El Sistema de ADP tiene como objetivo dotar a las instituciones de gobierno, a través de concursos públicos y transparentes, de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad.

Existe actualmente un problema profundo dentro de la estructuración de cargos de ADP del sector, dado el gran número de vacantes. Al respecto, el estado de cargos de los Servicios de Salud del Primer Nivel Jerárquico, de un total de 29 cargos, trece se encuentran vacantes y en el segundo nivel de un total de 282 cargos, 148 se encuentran vacantes.

En menor proporción se identificó que en el segundo nivel jerárquico de los ADP Centro de Referencia de Salud (CRS), de un total de seis cargos, existen actualmente dos vacantes. Respecto a los autónomos cuentan con un total de 32 cargos y diez se encuentran vacantes, de este total solo uno corresponde al primer nivel jerárquico, correspondiente al director de Cenabast.

Esto en términos institucionales es un problema grave y de suma relevancia que afecta diferentes aspectos estratégicos, generando debilitamiento de la conducción estratégica, discontinuidad de la gestión o menor capacidad de gestión, aumento del riesgo operativo y administrativo y pérdida de legitimidad institucional.

Resolver esta crisis estructural es un desafío fundamental para retomar el control institucional a través de acciones como formalizar e integrar los nuevos lineamientos estratégicos ministeriales, en los perfiles de cargo, para asegurar el ejercicio de alineación con los objetivos y metas que se establecerán en los nuevos convenios de desempeño de los altos directivos, se requiere también mantener las bases de datos actualizadas sobre la vacancia y provisión de cargos del primer y segundo nivel jerárquico, incluyendo sus respectivos órdenes de subrogancia.

- Reasignación cartera Fonasa - Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC)

Con fecha 24 de mayo de 2024 se publicó la Ley N° 21.674, denominada “Ley Corta de Isapres”, la cual creó, en lo pertinente a Fonasa, la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). Desde la publicación de la ley, Fonasa ha desarrollado los componentes estructurales del modelo: el arancel MCC, las pólizas de incorporación individual y colectiva, y una red de prestadores privados a nivel nacional. Asimismo, se llevaron a cabo dos procesos licitatorios para la contratación de compañías aseguradoras.

El segundo proceso permitió adjudicar solo una de las siete fracciones de riesgo contempladas. Las gestiones posteriores de contratación directa para las fracciones restantes no fueron fructíferas, al no ser posible concretarlas sin modificar condiciones esenciales del modelo definido en las bases de licitación.

Dado que la contratación de la totalidad de las fracciones constituye un requisito indispensable para la implementación del modelo de la segunda licitación de la MCC, Fonasa ha definido dejar sin efecto la adjudicación parcial y declarar desierta la referida licitación.

Lo anterior, permite a Fonasa continuar con la implementación de la MCC, evaluando eventuales ajustes al modelo u otros elementos esenciales.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2025-2026

1. Cáncer

a. Decretar alerta sanitaria.

Con fecha 15 de abril de 2026, se publica en el Diario Oficial la Alerta Sanitaria Oncológica, siendo este uno de los compromisos iniciales del gobierno. Esta medida reconoce el retraso existente en las garantías de oportunidad GES y en listas de espera No GES como una situación crítica y que corresponde a un problema relevante de salud pública para la población.

Esta alerta sanitaria otorga al Ministerio de Salud facultades extraordinarias para poder acelerar la atención de aproximadamente 30.000 pacientes que se encuentren en espera de diagnóstico o tratamiento. Entre sus principales alcances se incluye la contratación de personal, la adquisición expedita de bienes y servicios, la coordinación de la red asistencial, además de la implementación de un Plan Operativo Nacional para la resolución de listas de espera oncológicas. Esto constituye un avance relevante en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema frente a esta crisis sanitaria oncológica.

b. Plan de Resolución

Se elaboró un Plan Operativo Nacional de Resolución de Listas de Espera Oncológica No GES y GES retrasados con el objetivo de contactar a la totalidad del universo definido, caracterizar su situación actual y gestionar la resolución de prestaciones pendientes y dar inicio al Diagnóstico, Tratamiento o Seguimiento, según corresponda.

- Implementación del Plan

La implementación del plan es una estrategia secuencial e interdependiente que avanza desde la identificación de los pacientes hasta la resolución efectiva de sus prestaciones, bajo un sistema de monitoreo continuo y transversal a todo el proceso.

- Identificación y validación de casos

La primera etapa comprende la revisión y actualización sistemática de la información de cada caso, mediante la conciliación entre los registros del nivel central, especialmente SIGGES, y los sistemas locales de los Servicios de Salud. Este proceso permite verificar la situación vigente de cada paciente con prestaciones retrasadas, depurar duplicidades e inconsistencias y consolidar un universo nominal validado como base para la gestión posterior.

- Vinculación y programación de la atención

La segunda etapa consiste en la vinculación activa con la totalidad de las personas comprendidas en el universo validado, la caracterización de su situación clínica y social actual, y la definición de una fecha comprometida para la resolución de la prestación pendiente. Para ello, se contempla un protocolo multicanal escalonado, que incorpora mensajería, llamada telefónica y, de ser necesario, visita domiciliaria, con seguimiento hasta confirmar la vinculación efectiva de cada caso.

- Resolución integral de prestaciones

La tercera etapa comprende la ejecución de las atenciones requeridas para los casos ya vinculados y programados. La estrategia de resolución considera la optimización de la capacidad instalada de la red, la reorganización territorial de la oferta asistencial entre Servicios de Salud y, cuando la capacidad pública resulte

insuficiente, la activación de mecanismos de compra de servicios al sector privado, conforme a tarifas y estándares previamente definidos.

- Gobernanza y monitoreo

La implementación opera bajo una gobernanza en tres niveles: coordinación estratégica desde el nivel central, gestión territorial por parte de los Servicios de Salud y ejecución directa en los establecimientos de la red asistencial. El seguimiento se desarrolla mediante un sistema de monitoreo nominal semanal, con reporte de avances por Servicio de Salud, especialidad y etapa del proceso, junto con la gestión oportuna de alertas y nudos críticos frente a desviaciones en el cumplimiento de las metas establecidas.

En su conjunto, esta estrategia busca no solo administrar un rezago, sino asegurar trazabilidad, acelerar la resolución efectiva de prestaciones y restituir oportunidad de atención a pacientes cuya espera ya genera un riesgo sanitario relevante.

- Resguardos, control y probidad

La medida no entrega facultades sin control. Tiene vigencia acotada hasta el 30 de septiembre de 2026. El decreto además exige cumplimiento estricto de las normas de probidad, prevención de conflictos de interés y controles mínimos definidos por la Contraloría General de la República.

La Contraloría tomó razón del decreto con alcances expresos. En particular, precisó que las prestaciones vinculadas a problemas oncológicos deben regirse por condiciones económicas ya definidas o, cuando corresponda, por arancel Fonasa. La alerta, por tanto, no es discrecionalidad sin límites, sino una herramienta excepcional sometida a reglas y control.

c. Lanzamiento del segundo prestador automático al vencerse la garantía de oportunidad en Casos de Cáncer.

Reducir los tiempos de espera en el ámbito oncológico es una de las prioridades fundamentales. Con el objetivo de asegurar la continuidad y oportunidad de la atención, durante el período 2025 y el primer semestre de 2026 se ha avanzado en la implementación de un modelo de derivación y resolución escalonada centrado en las personas.

Este modelo considera, en primer término, la identificación y vinculación efectiva de los pacientes, con información clínica disponible y contacto activo. Luego la evaluación de resolución en el hospital de origen en un plazo acotado de entre siete y diez días hábiles. Y finalmente, en caso de requerirse, la derivación dentro de la red pública con extensión horaria para aumentar la capacidad resolutiva. Cuando la red pública no logra dar respuesta oportuna, se activa el segundo prestador, incorporando la red privada como complemento. En este contexto, se ha fortalecido la capacidad del segundo prestador, alcanzando 26 instituciones privadas en convenio con resolución oncológica, junto con la ampliación de la red mediante nueve instituciones con capacidad oncológica acreditada.

Este despliegue se articula a nivel nacional y se sustenta en un monitoreo transversal y nominal semanal, permitiendo hacer seguimiento a cada caso según servicio de salud, especialidad y estado de resolución. Todo lo anterior refuerza un enfoque donde la red privada actúa como complemento de la capacidad pública, contribuyendo a mejorar la oportunidad de atención sin sustituir el rol estructural del sistema público de salud.

d. Ley Nacional del Cáncer Nº21.258

La Ley Nacional del Cáncer establece el marco para políticas integrales de cáncer orientadas a reducir la morbimortalidad, aumentar la sobrevida y mejorar la calidad de vida de las personas con algún diagnóstico oncológico. Su instrumento rector es el Plan Nacional de Cáncer, llevado a la práctica mediante el Plan de Acción, que traduce los objetivos estratégicos en acciones concretas, metas e indicadores para todo el continuo de

atención. El instrumento rector vigente comienza en 2026 su proceso de actualización para el quinquenio 2028–2032.

El alcance de esta Ley en todo el territorio nacional abarca las 16 regiones del país a través de los 29 Servicios de Salud, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y la red de Atención Primaria. Su implementación es liderada por la Subsecretaría de Salud Pública con participación de la Comisión Nacional del Cáncer, Fonasa, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), hospitales públicos y la academia, entre otros actores. Territorialmente, el fortalecimiento se refleja en la conformación de Mesas Regionales Integradas en trece de las 16 regiones y de planes regionales de cáncer en siete regiones: Antofagasta, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Aysén.

Los principales logros alcanzados en materia de cáncer para el periodo 2025-2026 y en el marco del seguimiento del Plan Nacional del Cáncer 2022-2027, se han efectuado evaluaciones semestrales, registrándose en las tres últimas un cumplimiento promedio de 66,5 por ciento. A la fecha, se encuentra en desarrollo la evaluación correspondiente al segundo semestre de 2025.

Durante el primer año de implementación conjunta del Plan Adulto y el Plan Nacional de Cáncer Infantoadolescente 2023–2028, se ejecutaron 169 compromisos.

La segunda Comisión Nacional del Cáncer fue establecida mediante Decreto Exento N°30 del quince de mayo de 2025, en funciones desde el dos de diciembre de 2024. Durante el cuarto trimestre de 2025 brindó asesoría en plan de inversiones, brechas de conocimiento, actualización del Plan 2028–2032, impacto socioeconómico del cáncer y desarrollo de la red de asesoramiento genético.

En materia de personal de salud especializado durante el periodo se cuenta con 236 profesionales médicos en formación en trece especialidades oncológicas, con 81,4 por ciento con obligación de devolución. 264 profesionales médicos en período de devolución, distribuidos en todas las regiones del país. Además, se han desarrollado 157 acciones formativas, cursos, diplomados, talleres, pasantías, en áreas como psicooncología, cuidados paliativos, rehabilitación, nutrición y enfermería oncológica, capacitando a dos mil 783 funcionarios.

Con relación a la Red oncológica nacional, fue aprobada la “Orientación Técnica para el funcionamiento del comité oncológico”, instancia que articula la atención en la red de 132 establecimientos reconocidos como centros oncológicos, once de alta, 29 de mediana y 92 de baja complejidad.

En el año 2025 se realizó el primer concurso público con presupuesto de 215 millones 694 mil pesos. Se recibieron 60 postulaciones, 27 admisibles. Los proyectos adjudicados corresponden a autotoma molecular extendida y colposcopía digital por el monto de 122 millones 850 mil pesos y quimioterapia intraarterial hepática por bomba por 92 millones 844 pesos. Esto en el contexto del Fondo Nacional del Cáncer.

Durante 2025, la Comisión de Drogas de Alto Costo, se reestructuró en su funcionamiento, dependencia y composición, incorporando por primera vez representantes de sociedades científicas. En cuanto a cobertura farmacológica, se sumó el financiamiento de pembrolizumab para cáncer de mama triple negativo y a principios del año 2026, se publicó la resolución de drogas oncológicas No GES, que formaliza la incorporación de nivolumab para tres nuevas indicaciones: cáncer urotelial, cáncer pulmonar y mesotelioma irresecable en combinación con ipilimumab. Por último, en términos presupuestarios, se observa un crecimiento sostenido, pasando de 61 mil 760 millones de pesos en 2022 a 91 mil 224 millones de pesos proyectados para este año 2026.

En el marco del Decreto GES 2025-2028 se actualizaron las canastas de cáncer cervicouterino y leucemia permitiendo el diagnóstico molecular de VPH para mujeres de 35 a 45 años y seis nuevos esquemas de tratamiento para leucemia, respectivamente.

- Prevención y control del cáncer en APS

En esta línea hubo una recuperación significativa de coberturas y un inicio de expansión del tamizaje digestivo. Las mamografías aumentaron de 415 mil 515 en 2021 a 644 mil 868 en 2024, el PAP se recuperó de 43 por ciento a alrededor de 57 por ciento en diciembre de 2024, y el tamizaje digestivo pasó de cuatro Servicios de Salud en 2023 a 16 en 2025. La autotoma de VPH avanzó con trece mil 640 kits adquiridos; se capacitó a mil 600 profesionales en 2023 y se mantuvo Citoweb con cinco mil 499 perfiles habilitados. Un hito especialmente relevante es la implementación en 2025 de una regla predictiva para cáncer gástrico y condiciones premalignas, con identificación de casos de cáncer gástrico en niveles de prioridad alta o intermedia. Los desafíos son escalar a cobertura nacional la estrategia digestiva, aumentar mamografía a 70 por ciento y PAP a 80 por ciento al 2030, fortalecer estabilidad de equipos y abordar exigencias de calidad endoscópica y nuevas herramientas diagnósticas.

2. Tiempos de espera

a. Plan de Trabajo de Resolución de Tiempos de Espera de los Servicios de Salud

A diciembre de 2025, el número de registros en espera para Consultas Nuevas de Especialidad Médicas y Odontológicas asciende a dos millones 464 mil 738, correspondiente a dos millones 47 mil 191 personas. En este contexto, la mediana de espera se redujo a 226 días, lo que representa una disminución de 32,7 por ciento respecto a marzo de 2022. Por su parte, el promedio descendió a 323 días, equivalente a una reducción de 36 por ciento, a pesar de que el volumen de registros aumentó en 21,8 por ciento durante el mismo período. Cabe destacar que tanto la mediana como el promedio observado en diciembre de 2025 corresponden a los niveles más bajos registrados desde el año 2016.

En el caso de las intervenciones quirúrgicas, el número de registros en espera asciende a 425 mil 95, correspondientes a 371 mil 907 personas. En este período, la mediana de espera se redujo a 251 días, lo que representa una disminución de 48,8 por ciento respecto de marzo de 2022. Asimismo, el promedio descendió a 378 días, equivalente a una reducción de 37,4 por ciento, pese a que el volumen de registros aumentó en 28,6 por ciento. Al igual que en las consultas nuevas de especialidad, tanto la mediana como el promedio registrado a diciembre de 2025 corresponden a los niveles más bajos observados desde 2016.

Las cifras anteriores son el resultado de la implementación de medidas nuevas y de continuidad, enmarcadas en el Plan de Disminución de Tiempos de Espera. Estas se organizan en torno a tres ejes estratégicos, definidos para abordar de manera integral los principales desafíos de la red asistencial:

- Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la red asistencial

Orientado a incrementar la producción de prestaciones mediante un uso más eficiente de la capacidad instalada, junto con el cierre de brechas de oferta que limitan la resolución oportuna de la demanda.

- Mejora del acceso oportuno y centrado en las personas

Enfocado en acercar las soluciones a la población, mediante estrategias que faciliten el acceso, reduzcan barreras territoriales y aseguren continuidad de la atención a lo largo de la red.

- Modernización y transparencia de los sistemas de información

Dirigido a fortalecer la calidad, oportunidad y trazabilidad de la información sobre tiempos de espera, promoviendo una gestión más eficiente de la demanda y mayor transparencia hacia la ciudadanía.

b. Resolución de Lista de Espera con financiamiento Extraordinario (RELE)

En 2025 se implementó el Programa de Resolución de Listas de Espera (Rele), con un presupuesto total de 53 mil 345 millones 819 mil pesos, distribuido en dos decretos y ejecutado en dos etapas. La primera etapa, desarrollada entre el trece de agosto y el quince de octubre, reforzó la realización de cirugías mayores y menores, consultas nuevas de especialidades médicas y odontológicas, controles odontológicos, tratamientos oncológicos y acciones de contactabilidad con pacientes en lista de espera.

La segunda etapa se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025, mantuvo las líneas de trabajo anteriores, e incorporó el fortalecimiento transitorio de los equipos responsables de la gestión de registros. Asimismo, los recursos se focalizaron en los Servicios de Salud con mayor desempeño, con el objetivo de maximizar el impacto asistencial. Al cierre del programa RELE 2025, se registraron 193 mil 816 egresos de la Lista de Espera No GES por causales de atención, lo que representó un 90 por ciento de cumplimiento respecto de lo comprometido por la Red Asistencial.

Por su parte, el componente de contactabilidad se consolidó como un eje habilitante para la gestión de las listas de espera, complementando la resolución asistencial mediante acciones sistemáticas de contacto, seguimiento y revisión de fichas clínicas. En el marco de esta estrategia se registraron 176 mil 823 egresos, de los cuales 74 por ciento correspondieron a causales de atención (130 mil 241) y 26 por ciento a causales administrativas (46 mil 582).

3. Atención Primaria de Salud (APS)

a. Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) y Estrategia de Cuidado Integral Centrado en la Persona (ECICEP)

Se ha consolidado el MAIS como marco organizador del cuidado integral, con instalación de capacidades en equipos de salud, incluyendo 550 facilitadores formados y más de 66 mil personas capacitadas. Asimismo, se observa un aumento significativo en su implementación, con centros autoevaluados que pasan de 701 a mil 015, junto con un incremento relevante en ingresos, controles y seguimientos integrales.

b. Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF)

Se avanzó en la actualización conceptual y operativa del programa, mediante una nueva resolución y orientación técnica alineadas con el MAIS y con un enfoque de mejora continua. A diciembre de 2025, existen 294 establecimientos con código DEIS de CECOSF, que atienden a un millón 174 mil 948 personas, y se alcanzó un 96,5 por ciento de cumplimiento, respecto de los estándares definidos en la pauta de autoevaluación MAIS.

c. Equidad en Salud Rural

Se fortaleció la respuesta en territorios rurales mediante mejora de las evaluaciones familiares y el registro de planes de intervención en familias con situación de riesgo. Además, se logra un aumento de la conectividad satelital de Postas de Salud Rural (PSR) alcanzando un 88 por ciento del total en 2025. Adicionalmente, se implementaron pilotos de kits de telemedicina en los Servicios de Salud de Ñuble y Araucanía Sur, y se realizó un levantamiento nacional de información de PSR en 2025.

d. Más Salud en Comunidad

Durante el año 2026, se ha impulsado la implementación del Programa Más Salud en Comunidad, como una estrategia que consolida el enfoque preventivo–promocional de la Atención Primaria y articula intervenciones a lo largo del curso de vida con base territorial. Este programa integra y reorganiza la oferta existente (Vida Sana, Detección, Intervención y Referencia Asistida, Salud Escolar y Cuidados Comunitarios), fortaleciendo la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la detección precoz y la continuidad del cuidado. Esto

incorpora activamente a la comunidad en la identificación de necesidades y en la implementación de soluciones locales. De esta manera, se fortalece la participación ciudadana y se avanza en intervenciones más pertinentes, oportunas y de mayor impacto sanitario y social.

e. Atención Primaria de Salud Universal

La APS Universal, en su creación, busca garantizar el acceso al primer nivel de atención a toda la población, independiente de su previsión, fortaleciendo la capacidad resolutiva de la Atención Primaria. El diseño se estructura en base a la inscripción universal, reducción de las barreras de acceso principalmente mediante las extensiones horarias y actividades extramurales, y el fortalecimiento de la participación social. Los resultados principales fueron la inscripción de 316 mil 74 nuevas personas en las comunas pioneras, de las cuales sólo 32 mil 63 personas no eran FONASA; un aumento en la utilización de servicios en comunas pioneras de 67,42 por ciento a 68,45 por ciento en 2024; la instalación de internet satelital en 470 postas rurales; y un aumento del 11,8 por ciento del uso de telesalud. Actualmente se encuentra implementado en 28 comunas, siendo el plan inicial incorporar a 170, sin embargo, esta estrategia se asocia a una expansión importante de recursos que no se vio reflejada en el presupuesto. Por esto, y por los modestos resultados obtenidos luego de casí cuatro años de implementación, por lo que la estrategia se encuentra actualmente en un proceso de redefinición, priorizando la prevención como eje fundamental en lugar de la universalización, y buscando mantener aspectos positivos como la telesalud y conectividad.

f. Telesalud

La estrategia de telesalud constituye uno de los avances más visibles en materia de modernización del acceso a la atención de salud, llegando a más de 4 millones 193 mil solicitudes durante el 2025, y al cierre del primer semestre 2026 se alcanzaron más de 2 millones 991 mil solicitudes de atención. En este ámbito, se han desarrollado pilotos orientados a fortalecer la continuidad del cuidado, incorporando mecanismos como la derivación post-urgencias y la coordinación con el Hospital Digital, lo que permite dar mayor seguimiento a los pacientes dentro de la red asistencial.

Asimismo, se han integrado en los protocolos de atención los lineamientos establecidos por la ley de acceso preferente, contribuyendo a mejorar la oportunidad de atención para grupos prioritarios. De manera complementaria, se ha ampliado progresivamente la cobertura de la estrategia, incorporando establecimientos de atención primaria como CESFAM y CECOSF, así como hospitales comunitarios, extendiéndose desde el año 2025 a las postas de salud rural, con el objetivo de reducir brechas de acceso, especialmente en territorios con mayor dispersión geográfica.

g. Cuidados paliativos universales en APS

Esta línea presenta uno de los mayores crecimientos en instalación y cobertura. Se instalaron referentes técnicos en Servicios de Salud y comunas, equipos clínicos según lineamientos, comités de cuidados paliativos y mecanismos de articulación en red entre APS y nivel secundario. Los ingresos al programa pasaron de 13.548 personas en 2023 a 21.239 en 2025, y los ingresos por condiciones no oncológicas de 10.131 a 15.921. Las atenciones domiciliarias aumentaron de 157.631 a 519.606, mostrando un crecimiento significativo de la capacidad de respuesta territorial.

h. Sistemas de información en salud.

Durante el período 2025–2026 se fortalecieron las bases para una gestión sanitaria más integrada, mediante el desarrollo y expansión de herramientas digitales orientadas a mejorar la trazabilidad de la atención y la toma de decisiones. Destaca la consolidación de plataformas como telesalud y el avance en el uso del Sistema de Información Territorial en Salud (SITS), que permiten una mejor gestión de la demanda, priorización clínica y seguimiento de la población a cargo.

i. Metas sanitarias e instrumentos de desempeño

Durante el período 2025–2026 se fortaleció el uso de instrumentos de monitoreo y gestión del desempeño en Atención Primaria, particularmente a través del Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud (IAAPS) y el seguimiento de metas sanitarias. Estas herramientas han permitido dar seguimiento a la recuperación de coberturas post pandemia, especialmente en controles de salud, enfermedades crónicas y prestaciones preventivas.

Para el año 2026, se incorporan nuevas metas IAAPS orientadas a fortalecer el uso efectivo de los servicios de salud y abordar resultados sanitarios prioritarios, destacando aquellas vinculadas a la reducción de hospitalizaciones evitables, avanzando desde una lógica centrada en la producción de actividades hacia una gestión basada en resultados, incentivando la resolutividad de la APS.

j. Financiamiento y gestión en APS

Durante el período 2025–2026 se avanzó en la consolidación de mecanismos de gestión y financiamiento, los cuales permiten sostener la implementación de las estrategias priorizadas en Atención Primaria. En particular, se ha fortalecido la articulación entre el financiamiento per cápita y los Programas de Reforzamiento de la APS (PRAPS). Lo anterior permitió dar continuidad a la operación de los establecimientos, apoyar la implementación de estrategias sanitarias y responder a necesidades territoriales específicas. Asimismo, se han realizado ajustes en la asignación y ejecución de recursos, orientados a mejorar la oportunidad de las transferencias y su coherencia con las prioridades sanitarias. Esto incluye el fortalecimiento de líneas como salud respiratoria, pesquisa de cáncer y continuidad del cuidado.

En este contexto, durante el año 2026 se ha priorizado el fortalecimiento de la red de urgencia en APS, mediante la expansión de recursos destinados a dispositivos de atención inmediata, tales como Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) y Servicios de Urgencia Rural (SUR). Esta línea de acción permite incrementar la capacidad de respuesta frente a la alta demanda asistencial, especialmente en períodos de mayor presión estacional. Contribuyendo a mejorar la oportunidad de atención, descongestionar otros niveles del sistema y reforzar el rol resolutivo de la Atención Primaria.

4. Salud Digital

Durante 2025 y el primer semestre de 2026, el Departamento de Salud Digital continuó consolidando una red nacional de atención remota al servicio de las personas y de la Red Asistencial mediante sus estrategias de Telemedicina Sincrónica, Asincrónica y de Apoyo Diagnóstico, a través del Hospital Digital, se mantuvo la operación continua de esta estrategia en los 29 Servicios de Salud.

En 2025 se realizaron más de 974 mil prestaciones clínicas, y al cierre del primer semestre de 2026 ya se registraban más de 487 mil nuevas atenciones, proyectando un nuevo año de alta actividad asistencial y reafirmando el rol estratégico de la Salud Digital en el fortalecimiento del sistema público de salud.

Asimismo, durante este período se amplió la cartera de prestaciones, incorporando nuevas especialidades o diagnósticos como Pterigión en Oftalmología, Endocrinología pediátrica y Cuidado Avanzado de Heridas alcanzando un total de 33 especialidades implementadas a nivel nacional a junio 2026, con la proyección de llegar a 38 especialidades al cierre de este año.

También se consolidaron telecomités clínicos especializados en oncología, radioterapia, hematología y otras áreas de alta complejidad, fortaleciendo la coordinación entre equipos de salud y mejorando la oportunidad diagnóstica y terapéutica.

En paralelo, se impulsó el uso de Inteligencia Artificial aplicada a salud pública, destacando estrategias de tamizaje para retinopatía diabética, apoyo en mamografía y el desarrollo de algoritmos con enfoque ético y

centrado en las personas. Asimismo, se fortalecieron los canales digitales de vinculación con la ciudadanía, incorporando nuevas funcionalidades en el Portal Paciente, como el acceso a certificados de vacunas, superando el millón 200 mil ingresos acumulados sólo en el primer semestre de 2026.

Estos avances han permitido entregar una atención más oportuna, disminuir traslados innecesarios, acercar especialistas a zonas alejadas, fortalecer la continuidad del cuidado y modernizar la gestión clínica de la red asistencial.

5. Otras prioridades

a. Estrategia Nacional de Prevención en Salud

En febrero del 2026 se aprobó la Norma Chilena NCh 3433, titulada “Promoción de Salud en el Trabajo – Requisitos” por el Consejo Técnico de Instituto Nacional de Normalización (INN). La Norma genera estándares que pueden ser implementados por cualquier empresa o institución pública.

b. Tabaco

- Fortalecimiento del Control Tabáquico

La Ley N°21.642, vigente desde febrero de 2025, regula el uso y comercialización de cigarrillos electrónicos, incorporando los vapeadores al control sanitario con el objetivo de proteger a la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes, de la exposición y dependencia a la nicotina. La normativa prohíbe su venta a menores de 18 años, exige advertencias sanitarias y establece la obligación de transparentar la composición de estos productos ante el Ministerio de Salud.

Asimismo, esta ley equipara la regulación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Sin Nicotina (SESN) a la de los productos de tabaco tradicionales, restringiendo su venta y consumo en espacios públicos y cercanos a establecimientos educacionales, y fortaleciendo los mecanismos de fiscalización mediante sumarios sanitarios. Complementariamente, la Resolución Exenta N°1.085 fija los requisitos para su comercialización, incluyendo la declaración obligatoria de componentes, cuyo incumplimiento impide su venta en el país.

- Acceso Universal a Terapias (Nuevo GES)

Frente al impacto del tabaquismo, con 52 muertes diarias y un costo equivalente al 3,2 por ciento del PIB, se logró incorporar el tratamiento de cesación para personas mayores de 25 años al GES, marcando un avance relevante en salud pública y equidad en el acceso.

Desde diciembre de 2025, esta medida garantiza cobertura integral y gratuita para personas de 25 años y más pertenecientes al sistema público de salud que desean dejar de fumar, incluyendo farmacoterapia y apoyo psicológico individual y grupal. Asimismo, permite a personas del sistema privado acceder a estas prestaciones con copago reducido, fortaleciendo el acompañamiento efectivo en el proceso de cesación.

- Recuperación de Espacios Públicos y ambientes libres de humo

A partir de mayo de 2025, se fortaleció la normativa al prohibir fumar y vapear en lugares cerrados. Avanzando de manera concreta en la protección del derecho de la población a respirar aire libre de humo en lugares como estadios, gimnasios y centros comerciales. Paralelamente, la Subsecretaría de Salud Pública impulsó la actualización del concepto "espacio cerrado" ante la Contraloría General de la República, con el fin de ampliar el alcance de la fiscalización sanitaria, incorporando estructuras semicubiertas y alineando la regulación con estándares internacionales.

c. Salud bucal

Durante 2025, la Mesa Nacional Intersectorial de Salud Bucal impulsó diversas iniciativas orientadas a fortalecer el trabajo de las mesas regionales y de los equipos educativos que participan en la estrategia Sembrando Sonrisas. Entre los principales avances destacan la actualización del material educativo dirigido a las familias de párvulos, a través del cuaderno viajero “Familias que Siembran Sonrisas”; la actualización del curso “Herramientas para el cuidado de la salud bucal”, destinado a personal educador y disponible en el campus virtual de la Organización Panamericana de Salud (OPS); y el desarrollo de actividades de difusión sobre la estrategia Sembrando Sonrisas y el cuidado de la salud bucal, dirigidas a equipos educativos y familias, mediante webinars y boletines digitales.

Asimismo, de acuerdo con registros del Ministerio de Salud, durante 2025 se realizaron 504 mil 088 exámenes de salud bucal a niños de dos a cinco años en establecimientos de educación parvularia del país, prestación trazadora de la estrategia Sembrando Sonrisas.

d. Prevención y control del consumo de alcohol

Durante el último año, se vigilaron cerca de seis mil piezas de publicidad de bebidas alcohólicas difundidas a través de medios como televisión abierta, prensa, vía pública, televisión pagada, radio y plataformas digitales, incluyendo redes sociales, YouTube y buscadores de internet. A partir de este monitoreo, se constató que aproximadamente el 90 por ciento de la publicidad emitida en el país cumple con la normativa vigente. No obstante, el diez por ciento correspondiente a incumplimientos fue remitido a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, para que, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, fiscalicen a los regulados y adopten las sanciones que correspondan.

e. Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Dada la complejidad de las causas asociadas al VIH y las ITS, el Programa de Salud Pública logró ampliar y profundizar la respuesta preventiva del país. Esto permite que las personas puedan decidir de manera más informada y autónoma sobre la gestión de su riesgo individual y colectivo, contribuyendo así a evitar la transmisión de estas infecciones en la población. Asimismo, se avanzó en disminuir la morbimortalidad por VIH/SIDA e ITS, facilitando el acceso oportuno a diagnóstico, control y tratamiento. Para ello, se fortalecieron las estrategias de Prevención Combinada del VIH recomendadas por organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud (OMS), OPS y ONUSIDA). Los ejes centrales de estas estrategias son la disponibilidad y entrega de insumos preventivos, incluyendo la prevención farmacológica (Profilaxis Preexposición (PrEP) y Profilaxis Postexposición (PEP)), la distribución de preservativos, la entrega de información y educación a la población, y la ampliación de la oferta de exámenes para el diagnóstico y tratamiento del VIH y las ITS.

Al mismo tiempo, se avanzó en la prevención de la transmisión vertical del VIH y las ITS, contribuyendo al logro de las metas de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis. Esto ha permitido evitar de forma significativa nuevos casos de VIH en niños (hijos de madres con VIH) y de sífilis congénita en el país.

Con el objetivo de fortalecer la respuesta nacional frente al VIH, incorporaremos una nueva garantía en el GES que amplía las alternativas terapéuticas para personas con mayor riesgo clínico, permitiendo una atención más personalizada. Esta medida mejora la seguridad y tolerabilidad del tratamiento, favoreciendo una mayor adherencia y una mejor calidad de vida. Además, refuerza el principio de que una persona que alcanza y mantiene una carga viral indetectable no transmite el VIH por vía sexual (Indetectable=Intransmisible), aportando al cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile en la respuesta mundial frente al VIH, esto comenzará a regir el primer semestre del próximo año

f. Estrategia Nacional para detener la aceleración del sobrepeso y obesidad en Niñas, Niños y Adolescentes

Durante 2025 se concretaron importantes avances en el marco de las acciones comprometidas por la estrategia, orientados a fortalecer la promoción de entornos saludables, mejorar la respuesta del sistema de salud y consolidar herramientas para la prevención de la malnutrición en todas sus formas. Entre los principales hitos destacan la oficialización de la Orientación Técnica para Servicios de Alimentación y Nutrición; el lanzamiento del Tablero de Vigilancia del Estado Nutricional del Ministerio de Salud, constituyendo un avance relevante en transparencia, monitoreo y acceso a información; y la implementación de un curso sobre las Guías Alimentarias para Chile, dirigido a personas vinculadas con el sistema alimentario para fortalecer capacidades en promoción de alimentación saludable.

Asimismo, se avanzó en medidas estructurales para fortalecer el enfoque de curso de vida, destacando la oficialización de la Norma para la Implementación y Funcionamiento de los Bancos de Leche Humana en Chile, resguardando acceso equitativo a leche humana donada para prematuros y recién nacidos; la actualización de la Guía de Alimentación del Niño menor de dos años y de las Guías de Alimentación hasta la Adolescencia, incorporando nueva evidencia para promover prácticas saludables desde la primera infancia; y la conformación de una mesa técnica entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte para diseñar los lineamientos técnicos para implementar 60 minutos diarios de actividad física, juego o deporte durante la jornada educativa.

g. Arbovirosis

Durante el periodo junio 2025 – junio 2026 se destacan los siguientes avances:

- Implementación del Plan Nacional de Arbovirosis (Resolución Exenta N°332/2026), que estructura la respuesta sectorial frente al riesgo de transmisión autóctona en Chile continental, con activación progresiva según la situación epidemiológica y vectorial.

- Activación de vigilancia reforzada ante eventos vectoriales en cuatro regiones del país, Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y Metropolitana, con seguimiento de territorios priorizados bajo vigilancia vectorial.

- Gestión de brotes y eventos de riesgo: respuesta al brote de dengue en Rapa Nui (27 casos confirmados al 1 de julio de 2026) y contención de focos de Aedes aegypti en territorio continental, mediante intervenciones oportunas de control vectorial.

- Fortalecimiento de la detección precoz en la red asistencial, mediante vigilancia intensificada en servicios de urgencia y atención primaria, a través de dispositivos centinela de síndrome febril en regiones priorizadas.

- Implementación de acciones de control vectorial, incluyendo control de perifocos, vigilancia entomológica y medidas de manejo ambiental, en coordinación con municipios.

- Activación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para la gestión de eventos de arbovirosis, fortaleciendo la coordinación nacional e intersectorial en los territorios afectados.

- Desarrollo de capacidades técnicas mediante capacitaciones en vigilancia epidemiológica, control vectorial y manejo clínico, dirigidas a equipos de Seremi de Salud y Servicios de Salud en las regiones priorizadas.

6. Acuerdo de Riesgo Compartido (ARC)

El sistema de salud chileno enfrenta una creciente presión para financiar tecnologías sanitarias de alto costo, particularmente medicamentos innovadores para enfermedades poco frecuentes y patologías oncológicas. Estos tratamientos presentan altos niveles de incertidumbre clínica en condiciones reales de uso y generan un impacto

significativo en el gasto público, lo que se traduce en brechas de acceso, inequidades entre mecanismos de cobertura y aumento de la judicialización.

Los beneficiarios directos corresponden a pacientes del sistema público de salud que requieren acceso a medicamentos o tecnologías sanitarias de alto costo, particularmente en patologías oncológicas y enfermedades poco frecuentes. El total de beneficiados durante el año 2024, fueron cinco, el año 2025 aumentó a 80 y para el año 2026, se proyecta un total de 1990 pacientes.

Se proyecta que la implementación de ARC permitirá generar ahorros relevantes o contención del gasto en tecnologías de alto costo, además de mejorar el acceso de pacientes a terapias innovadoras.

- Institucionalización de la política

Creación de la Oficina de Coordinación de ARC (Resolución Exenta N°693, junio 2025).

- Implementación de acuerdos concretos

A partir del diálogo con la industria farmacéutica se han logrado importantes acuerdos, que han permitido dar acceso a medicamentos de alto costo y alta innovación en distintos sistemas de cobertura. Dentro de los cuales se destaca:

- Acuerdo por Trikafta® para fibrosis quística, incorporado en decreto GES 2025.
- Acuerdo por pembrolizumab en cáncer de mama triple negativo, incorporado en resolución de Drogas Oncológicas de Alto Costo (DAC) en septiembre de 2025.
- Acuerdo por nivolumab en tres indicaciones de cáncer, incorporado en resolución de Drogas Oncológicas de Alto Costo (DAC) en marzo 2026.

La inversión pública del ARC, al igual que su número de beneficiarios, ha aumentado significativamente. El año 2024 la inversión fue de mil 300 millones de pesos, aumentando por sobre el 85 por ciento en el año siguiente, con dos mil 409 millones de pesos. Para el año 2026 se tiene proyectado un incremento de dos mil 770 por ciento respecto al 2025, con 69 mil 207 millones de pesos.

En materia de desarrollo institucional, se avanzó en el fortalecimiento de capacidades para la implementación de los acuerdos, destacando la consolidación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para Acuerdos de Riesgo Compartido (ARC) y del Equipo de Diálogo con Proveedores, como instancias clave para la coordinación técnica y gobernanza del proceso. Asimismo, se desarrolló el Manual de Procedimientos para la implementación de Acuerdos de Riesgo Compartido, contribuyendo a estandarizar su operación, y se definieron los requerimientos funcionales y técnicos para una plataforma de monitoreo de resultados clínicos y financieros, orientada a fortalecer el seguimiento, evaluación y sostenibilidad de estos acuerdos.

7. Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF)

La Ley N°21.743 avanza en la implementación de un marco institucional para la identificación y registro de las personas con enfermedades poco frecuentes, mediante la definición de estas patologías, la elaboración y actualización bienal de un listado nacional, y la creación de un registro nacional con enfoque en fortalecer el diseño de políticas públicas.

Durante el período se han concretado la implementación de la Ley de EPOF, mediante la publicación del listado oficial de enfermedades poco frecuentes y la puesta en marcha del Registro de Personas con Diagnóstico EPOF (REPOF), capacitando a los equipos de salud, impulsando la conformación de una red nacional de referentes y la incorporación gradual de médicos tratantes para reforzar el registro y operación inicial de la plataforma.

8. Personas Mayores

a. Participar activamente en la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores

La actual administración levantó el veto a la Ley de Envejecimiento Integral, impulsando su tramitación tras años en el Congreso. Esta iniciativa prioriza la promoción del envejecimiento activo, el fomento de hábitos saludables y la prevención de enfermedades mediante detección precoz, intervenciones oportunas y cuidados integrales orientados a evitar la dependencia.

En este contexto, desde el Ministerio de Salud, se ha definido retomar el desarrollo del Plan Nacional de Salud Integral para las Personas Mayores y su Plan de Acción 2020-2030. Este plan tiene como objetivo "mejorar el bienestar de las personas mayores a través de un sistema de salud integral que les permita mantener y mejorar su estado de salud y funcionalidad, accediendo a prestaciones acordes a sus necesidades mediante un trabajo intersectorial coordinado, niveles asistenciales articulados e integrados, y con participación de la sociedad en su conjunto". Asimismo, el plan busca contribuir a la implementación de esta ley y alinearse con las diversas recomendaciones e iniciativas internacionales tales como: la puesta en práctica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Organización de Naciones Unidas) y la Década para el envejecimiento saludable 2020-2030, entre otros.

En relación con lo anterior y siguiendo la hoja de ruta formulada en el plan nacional, se han realizado las siguientes iniciativas:

b. Mejorar el acceso a actividades de promoción de la salud.

- Generación de guías de alimentación saludables para personas mayores.
- Reformulación del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (Pacam).
- Proceso de actualización del Examen de Medicina preventiva del Adulto Mayor (Empam): Se encuentra en proceso una actualización que fortalece su enfoque integral y centrado en la persona, priorizando la detección temprana de fragilidad, la intervención y el seguimiento. Además, la nueva versión suma escalas para la evaluación de dominios importantes en la salud integral de personas mayores como adherencia a tratamiento farmacológico, audición, riesgo de caídas, soledad y aislamiento involuntario.

c. Disminución en prevalencia de enfermedades neumocócicas e influenza.

Articulación de la red de salud para fortalecer la vacunación de la población de riesgo, priorizando la inmunización contra influenza y enfermedad neumocócica. Asimismo, se reforzó la coordinación con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) para ampliar la cobertura de vacunación de las personas residentes en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).

Actualización del calendario de vacunación 2026 del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) contra el neumococo, incorporando las recomendaciones del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI). La actualización considera el reemplazo de la vacuna conjugada 13-valente (PCV13) por la vacuna conjugada 20-valente (PCV20) en lactantes, la sustitución de la vacuna polisacárida 23-valente (PPSV23) por la vacuna conjugada 21-valente (PCV21) en personas de 60 años y más, y la reducción de la edad de inicio de la vacunación contra el neumococo de 65 a 60 años.

d. Disminución de los tiempos de espera para Personas Mayores

Seguimiento a la implementación de protocolos locales en la red asistencial de salud para la ejecución del Reglamento asociado a la Ley N°21.168, publicada en 2019, que modifica la Ley N° 20.584 en Chile para crear el derecho a la atención preferente y oportuna en salud. Esta ley beneficia a personas mayores de 60 años y

personas con discapacidad, sumándose posteriormente la Ley N°21.380, que otorga este mismo beneficio a cuidadoras y cuidadores.

e. Modificación de normas y regulaciones

Actualización del decreto que regula la instalación y funcionamiento de ELEAM., ya sean públicas o privadas, vigentes a partir del 01 de octubre de 2025. Actualmente se avanza en el seguimiento de su cumplimiento y en el abordaje de las necesidades de las personas mayores institucionalizadas en el país.

f. Disminución del estigma y discriminación en Personas Mayores

Se promovieron encuentros intergeneracionales para reducir el edadismo, junto con el desarrollo de una guía metodológica, en conjunto con el Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento, para apoyar su implementación en los distintos niveles de atención.

g. Reducción de la sobrecarga de los cuidadores de personas mayores y fortalecer sus conocimientos y capacidades

Durante el año 2025, SENAMA inició un plan de formación para equipos de Centros Diurnos del Adulto Mayor (Cediam), orientado a fortalecer sus capacidades. En este marco, el MINSAL contribuye con capacitaciones en promoción de la salud, envejecimiento saludable, apoyo a personas con demencia y campañas de vacunación.

9. Licencias médicas (LM)

a. Elaborar un convenio tripartito que permita mejorar la tramitación de licencias médicas en especial en los casos de cáncer.

Este convenio tiene como objetivo asegurar tiempos de respuesta oportunos y mejorar la experiencia usuaria, especialmente en procesos de alta complejidad en el cual están involucrados otras instituciones como Fonasa y Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Su alcance es sectorial, Interministerial involucrando la coordinación entre el nivel central y organismos previsionales. Dentro de la población beneficiada usuarios de licencias médicas en procesos de recuperación de salud. También la población que requiere de los otros trámites realizados en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) como la calificación y certificación de discapacidad. Como principal logro se identificaron los cuellos de botella en la tramitación de licencias lo que permitió diseñar estrategias para la estandarización de criterios de evaluación a nivel nacional.

b. Modernizar y fortalecer las instituciones de salud

Elaboración del Plan Estratégico 2026 y diseño de la nueva estructura organizacional para subsanar la dilución del foco operativo orientándola a resultados y al monitoreo en tiempo real.

10. Salud Mental

a. Reforzamiento del Plan Nacional de Salud Mental con metas, y gobernanza intersectorial.

Durante el año 2025, se avanzó en el fortalecimiento del Plan Nacional de Salud Mental 2026-2037, definiendo un marco estratégico y programático para la próxima década. Se realizaron conversatorios en quince regiones con 765 representantes de organizaciones sociales, personas con experiencia vivida y equipos de salud. Además, se elaboró un marco estratégico con seis líneas prioritarias y una metodología participativa para su desarrollo.

b. Proyecto de Ley Integral de Salud Mental

Se impulsó el Proyecto de Ley Integral de Salud Mental, orientado a promover y proteger la salud mental a lo largo de todo el ciclo vital, basado en cuatro ejes: salud mental en todas las políticas; atención integral y de calidad; resguardo de derechos; e inclusión social. En 2025 se desarrollaron 27 diálogos ciudadanos con la

participación de dos mil 692 personas. El proyecto avanzó en su tramitación legislativa y, en marzo de 2026, fue aprobado en general por el Senado. Asimismo, se incorporó una indicación para ampliar la cobertura del Seguro para el Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (SANNA) a casos de riesgo alto de suicidio en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) hospitalizados.

c. Acceso a servicios de salud mental

Se fortaleció el acceso y la calidad de la atención en salud mental. Las prestaciones aumentaron de 3,2 millones en 2021 a 6,2 millones en 2025, con más de un millón de personas en control, principalmente en APS. También se implementó la estrategia mhGAP de la Organización Mundial de la Salud y se realizaron más de 860 mil tamizajes.

La red se aumentó con cinco nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar (COSAM), cinco equipos de Psiquiatría de Enlace, cinco Hospitales de día para adultos y tres Hospitales de día infanto-adolescentes. Además, se fortaleció la telepsiquiatría, beneficiando a más de seis mil 240 personas. El gasto en salud mental alcanzó el cuatro coma siete por ciento del gasto sanitario y se distribuyeron más de 958 mil cajas de medicamentos a bajo costo mediante Cenabast.

d. Prevención del suicidio

El Ministerio fortaleció la prevención del suicidio mediante coordinación intersectorial con Educación, Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Gendarmería, Carabineros, Metro y red de Salud. Se capacitó a 267 entrenadores y mil 226 agentes comunitarios en once regiones del país y se elaboró la primera Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio.

Asimismo, se implementó junto al Ministerio de Educación un protocolo de respuesta en 24 horas frente a intentos de suicidio en estudiantes, apoyando a 74 comunidades educativas durante su primer año.

e. Demencias

Se avanzó en la implementación del Plan Nacional de Demencia 2025–2035, orientado a mejorar la atención y calidad de vida de las personas con demencia y sus cuidadores mediante un enfoque sociosanitario e intersectorial. El plan contempla cinco ejes estratégicos y beneficiará directamente a entre 200 mil y 230 mil personas.

f. Abordaje del Autismo (implementación Ley N°21.545)

El Ministerio avanzó en la implementación de la Ley N°21.545 para fortalecer el tamizaje, diagnóstico y acompañamiento a personas autistas. Se capacitó a más de once mil funcionarios y mil 552 profesionales, y se elaboraron orientaciones técnicas y protocolos para la detección y seguimiento.

11. En APS, se habilitaron 86 salas con equipos multidisciplinarios en los 29 Servicios de Salud, alcanzando 18 mil 020 personas usuarias y cerca de 240 mil prestaciones realizadas entre 2024 y 2025. Además, entre 2024 y 2025 se incorporaron 105 equipos especializados a la red de salud mental; se fortalecieron 19 hospitales con médico Neurólogo y/o Pediatra y 49 hospitales con Fonoaudiólogos como parte de equipos de rehabilitación. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)

Anualmente se realiza la campaña de vacunación de invierno anti-influenza, contra COVID-19 y Virus Respiratoria Sincicial (VRS), para prevenir morbilidad grave y mortalidad, en grupos con mayor riesgo. Las coberturas alcanzadas durante la campaña 2025 y a la fecha durante la campaña 2026, se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N°4: Porcentaje de cobertura campaña de vacunación e inmunización 2025

Campaña	Vacunados 1° y única dosis	Población objetivo	% de Cobertura
Influenza	7.900.034	10.025.426	78,80
SARS-CoV-2	1.306.515	6.566.015	19,9
VRS Recién nacidos	84.218	86.195	93,0
VRS Lactantes	56.141	60.362	97,7

Fuente: División de Prevención y Control de Enfermedades, Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud.

Tabla N°5: Porcentaje de cobertura campaña de vacunación e inmunización 2026 (corte a julio 2026)

Campaña	Vacunados 1° y única dosis	Población objetivo	% de Cobertura
Influenza	7.795.233	10.033.617	77,69
SARS-CoV-2	575.532	6.875.549	8,37
VRS Recién nacidos	55.382	59.155	98,65
VRS Lactantes	56.819	56.819	96,05

Fuente: División de Prevención y Control de Enfermedades, Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud.

a. Estrategia de inmunización programática

La vacunación en Chile incluye 23 antígenos, y abarca todo el curso de vida, desde el recién nacido, lactantes, preescolares, adolescentes, adultos, embarazadas y personas mayores.

Esta estrategia ha alcanzado las coberturas que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla N°6: Porcentaje de cobertura inmunización programática 2026

Vacuna	Esquema	% de Cobertura
BCG	Recién nacido	98,7
Hepatitis B	Recién nacido	98,7
Hexavalente	1a dosis (2 meses)	98,0
	2a dosis (4 meses)	97,2
	3a dosis (6 meses)	95,9
	Refuerzo (18 meses)	90,9
Neumocócica conjugada	1a dosis (2 meses)	97,7
	2a dosis (4 meses)	97,2
	Refuerzo (12 meses)	94,3
Meningocócica recombinante (grupo B)	2 meses	98,7
	4 meses	97,4
	18 meses	83,5
Meningocócica conjugada tetravalente (ACYW-135)	12 meses	95,2
Sarampión, Rubéola y Parotiditis (tres vírica)	12 meses	95,3
	36 meses	79,7
Varicela	18 meses	90,8
	36 meses	80,5
Hepatitis A	18 meses	93,0
Fiebre Amarilla (Rapa Nui)	18 meses	67,3
dTpa (Tos convulsiva)	1° básico	92,9
	8° básico	88,1
Virus Papiloma Humano (VPH)	4° básico	90,4
dTpa (Tos convulsiva)	Embarazadas	82,7
Neumocócica polisacárida	65 años	54,7

Fuente: División de Prevención y Control de Enfermedades, Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud, Extracción 30 de junio 2026

b. Certificado de vacunas con firma electrónica avanzada.

Durante el periodo se disponibilizó a la población el historial de vacunas registradas en el Registro Nacional de Inmunizaciones desde el año 2021 en adelante. Las personas pueden acceder a su historial ingresando al Portal Paciente usando su clave única y descargar un certificado con su historial de vacunación certificada mediante firma electrónica avanzada. Además, los padres pueden acceder a la información de sus hijos hasta los catorce años.

c. Sistema de Control de Inventario.

Se realizaron mejoras en las funcionalidades del sistema de control de stock de las vacunas del Programa, permitiendo el seguimiento de las dosis disponibles desde el nivel nacional hasta el nivel ejecutor. Esto permitirá alcanzar la trazabilidad de punta a punta, llevando un mejor control del bien público.

d. Desarrollo del RNI 2.0.

Durante el periodo se desarrolló la versión 2.0 del Registro Nacional de Inmunizaciones. Esta versión ofrece mejoras tecnológicas y funcionales para optimizar la ejecución del Programa. Este nuevo software debiera ser puesto en operación durante el segundo semestre del 2026.

12. Gestión internacional

a. Foros multilaterales

- En 2025, el Ministerio de Salud fortaleció el liderazgo en espacios de salud global y regional, promoviendo temas como salud digital, atención centrada en la persona, financiamiento y decisiones basadas en evidencia.
- Chile consolidó una participación activa en la Organización Mundial de la Salud, impulsando acuerdos en materia de pandemias, financiamiento sanitario y cáncer cervicouterino.
- En la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Chile contribuyó al Plan Estratégico 2026-2031 y reafirmó su liderazgo regional, obteniendo la verificación de la eliminación de la lepra, siendo el primer país de las Américas en obtener este reconocimiento y segundo a nivel mundial.
- Se consolidó la articulación con organismos internacionales para avanzar en modernización, atención primaria y eficiencia del gasto en salud.
- Se fortaleció la colaboración entre Chile y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el marco del Plan Nacional del Cáncer, y la incorporación del país a estrategias de fortalecimiento de capacidades para el tratamiento del cáncer.
- Chile asumió la Secretaría Ejecutiva del ORAS-CONHU para el período 2026-2028, impulsando avances en cáncer infanto-adolescente, salud neonatal, embarazo adolescente, entre otras áreas prioritarias.

b. Cooperación bilateral y fronteriza:

- El Ministerio fortaleció la cooperación internacional y fronteriza con países de la región y socios estratégicos, avanzando en vigilancia epidemiológica, coordinación sanitaria, equipamiento hospitalario y mecanismos de respuesta ante urgencias y emergencias.
- Se mantuvo la cooperación bilateral con Costa Rica y Guatemala, en ámbitos como transformación digital y cáncer.

c. Ayuda humanitaria: Chile apoyó la respuesta sanitaria regional, mediante la donación de vacunas a Bolivia y Uruguay.

13. Recursos Humanos

a. Fortalecimiento de la dotación y capacidad operativa de la red pública

En el marco de la expansión de cargos para la puesta en marcha hospitalaria, durante el año 2025 se distribuyeron dos mil 692 cargos, con un financiamiento de siete millones 937 mil 570 pesos que incluye la entrada en operaciones de hospitales, COSAM y dispositivos oncológicos. Para 2026, se aprobaron dos mil 445 nuevos cargos (187 médicos y dos mil 258 profesionales y técnicos de salud), con un financiamiento de trece millones 540 mil 674 pesos. Estas medidas permitieron cerrar el 65 por ciento de la brecha de dotación en hospitales normalizados en 2025 y avanzar a un 69 por ciento en 2026. Dentro del Plan de Puesta en Marcha, se considera la entrada en operación de seis dispositivos oncológicos, seis nuevos COSAM y cinco que completan dotación para una población de 50 mil habitantes.

b. Formación, distribución y permanencia de especialistas en la red pública

El Plan de Formación de Especialistas contempla tres etapas: Destinación y Formación, para médicos y dentistas en zonas vulnerables; Especialización, dirigida a profesionales con experiencia en atención primaria; y el Período Asistencial Obligatorio, que asegura su permanencia en el sistema público. Al año 2025, el Plan alcanzó un total

acumulado de once mil 536 personas: once mil 125 médicos, 373 dentistas, 28 químicos farmacéuticos y diez bioquímicos.

c. Gestión del ausentismo laboral y continuidad operacional

En el año 2025 se evidencia una disminución del índice de ausentismo tras su punto más alto en 2022. El 92 por ciento de los establecimientos disminuyen su índice respecto a 2024, alcanzando incluso reducciones de hasta un 49 por ciento. Estos resultados reflejan un fortalecimiento en la gestión de personas y en las estrategias de bienestar laboral, contribuyendo a una mayor continuidad operativa y eficiencia en la atención de salud.

d. Modernización normativa, reconocimiento laboral y protección de derechos

- Protección a la Maternidad

Se avanzó en ajustes a la Ley N° 21.806, fortaleciendo la protección de la maternidad en el sector público de salud. La creación de cargos transitorios permite resguardar el fuero maternal sin afectar la continuidad de la atención ni la dotación autorizada.

Asimismo, se incorporaron medidas que limitan la jornada y excluyen el trabajo nocturno para funcionarias embarazadas en servicios de urgencia, promoviendo condiciones laborales más seguras y compatibles con la maternidad. Estas acciones refuerzan el compromiso con la equidad y el bienestar de las trabajadoras del sector salud.

14. Avances legislativos

a. Fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica. (Boletín N°17.397-1)

Esta iniciativa tiene por objetivo fortalecer el rol institucional de la Superintendencia de Salud, ampliando sus facultades de fiscalización y sanción sobre prestadores y aseguradores, perfeccionando los mecanismos de resolución de controversias y elevando los estándares de calidad y protección de los derechos de los pacientes en el sistema de salud, actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

b. Moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud; fortalece al Fondo Nacional de Salud; crea el Servicio Nacional de Salud Digital; otorga facultades al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y modifica normas que indica. (Boletín N°17.375-11)

Esta iniciativa busca modernizar el funcionamiento del sistema nacional de servicios de salud, fortaleciendo el rol de Fonasa como asegurador público e incorporando mecanismos para mejorar la eficiencia y productividad de la red asistencial. Contempla la creación del Servicio Nacional de Salud Digital y la ampliación de facultades del Instituto de Salud Pública y Cenabast, con el fin de optimizar la regulación, provisión y acceso a prestaciones, medicamentos y dispositivos médicos, se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado.

c. Establece la ley integral de salud mental y modifica los cuerpos legales que indica (Boletín N°17.003-1)

Esta iniciativa busca establecer un marco normativo integral en salud mental, reconociéndola como un componente esencial de la salud. Asimismo, define una institucionalidad intersectorial, regula la atención y hospitalización psiquiátrica, y promueve la prevención, la inclusión social y la protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental, se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado

d. Modifica el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común, introduce modificaciones en su aplicación al sector público, fortalece las facultades de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, y modifica las normas que indica. (Boletín N°17.678-11)

Esta iniciativa busca reducir el período de carencia del subsidio, equiparar las condiciones entre el sector público y privado, y fortalecer las facultades de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin). Incorpora mejoras en los mecanismos de control y fiscalización de las licencias médicas, con el objetivo de prevenir abusos y aumentar la eficiencia del sistema, se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado

e. Optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y modifica la Ley N° 20.850, que crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos. (Boletín N°17.567-11)

Esta iniciativa busca optimizar el mecanismo de sustentabilidad del Fondo de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, incorporando mayor flexibilidad en la asignación de recursos, mejorando los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias y ampliando la cobertura de tratamientos para las personas que enfrentan enfermedades de alto costo, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado

f. Modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal (Boletín N°15.850-11)

Esta iniciativa busca regular la comercialización de productos farmacéuticos, aumentando las sanciones por venta ilegal y falsificación, fortaleciendo las facultades fiscalizadoras del Instituto de Salud Pública (ISP) y tipificando nuevas conductas delictivas vinculadas al robo, distribución y prescripción fraudulenta de medicamentos, se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados,

g. Modifica el Código Sanitario, con el objeto de exigir a los establecimientos de venta de alimentos que señala, que proporcionen agua potable a sus clientes de forma gratuita (Boletín N°16.588-11)

Esta iniciativa busca establecer la obligación para los establecimientos de expendio de alimentos de poner a disposición de sus clientes, sin requerimiento previo, agua potable gratuita como servicio complementario, con el fin de promover hábitos de consumo más saludables, se encuentra en primer trámite constitucional de la Cámara de Diputados.

h. Da cumplimiento al inciso segundo del artículo décimo transitorio de la Ley Nº21.674; modifica el decreto con fuerza de Ley Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, en las materias que indica; pone fin a las enfermedades o condiciones preexistentes; elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud, y crea el plan común de salud de las instituciones de salud previsional. (Boletines N°17.147-11, 11.572-11 y 6.930-11)

Esta iniciativa da cumplimiento a lo establecido en la Ley N°21.674 y propone cambios estructurales al sistema de isapres, incluyendo eliminar las preexistencias y discriminaciones por edad y sexo. Establece la creación de un plan común de salud con coberturas y prestaciones uniformes, lo que permite avanzar en mayor equidad, transparencia y movilidad entre aseguradoras, fortaleciendo el acceso a condiciones más justas en el sistema privado de salud, se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

i. Modifica el Código Sanitario, para incorporar entre los servicios de los profesionales que señala, la adopción de acciones para prevenir la infertilidad (Boletín N°16.708-11)

Esta iniciativa busca incorporar la infertilidad dentro de los servicios de la matrona, y habilitar a las matronas y gineco-obstetras para indicar exámenes preventivos de infertilidad, conforme a un protocolo, se encuentra en segundo trámite constitucional de la Cámara de Diputados.

j. Modifica la ley N°20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, para promover la información y educación sobre la infertilidad (Boletín N°16.709-11).

Esta iniciativa busca incorporar expresamente la infertilidad entre las materias sobre las cuales el Estado debe entregar información, educación y orientación, integrándola a las políticas de salud sexual y reproductiva. Se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

k. Establece la prescripción médica mediante receta electrónica y sanciona su falsificación (Boletín N°17.355-11)

Esta iniciativa busca implementar la receta electrónica como mecanismo obligatorio, mejorando la trazabilidad de medicamentos y sancionando su uso indebido, se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado.

15. Gestión de emergencias y desastres

a. La División de Emergencias Sanitarias (DES) lideró la coordinación sectorial frente al tsunami de campo lejano registrado el 29 de julio 2025, provocado por un sismo de magnitud 8,8 en la cuenca del Pacífico, fortaleciendo la capacidad de respuesta oportuna del sistema de salud ante una amenaza de alcance internacional. Sobre la base de las evaluaciones técnicas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y de las medidas adoptadas por SENAPRED, la división articuló el monitoreo sanitario y la preparación de la red asistencial ante la declaración de Estado de Alerta para el borde costero de trece regiones y de Estado de Precaución para Aysén, Magallanes y el Territorio Antártico.

b. Se coordinó la respuesta a nivel nacional frente al aumento del riesgo de sarampión y la aparición de casos importados en Chile, reforzando la vigilancia, el seguimiento de contactos y las medidas de control. Se declaró alerta epidemiológica en marzo de 2025 y se activó un sistema de coordinación para la gestión de casos y la articulación con organismos internacionales. Las acciones incluyeron vacunación preventiva, seguimiento de contactos por 21 días, búsqueda activa de casos y comunicación de riesgo.

c. Se lideró la respuesta y la etapa de recuperación tras los incendios forestales de enero de 2026 en La Araucanía, Biobío y Ñuble, enfocándose en restablecer los servicios de salud, asegurar la continuidad de la atención y recuperar la red en las zonas más afectadas. En coordinación con los Servicios de Salud y mediante el Sistema de Comando de Incidentes, se definieron acciones para mantener la atención en un contexto crítico, marcado por cuatro mil 137 viviendas destruidas, más de 21 mil 803 personas damnificadas. En la fase de reconstrucción, se impulsaron iniciativas para recuperar la infraestructura y el equipamiento, priorizando proyectos críticos y destinando recursos tanto para obras como para el fortalecimiento de la atención en terreno. Además, se desplegaron equipos de salud comunitaria y salud mental, junto con dispositivos móviles, para apoyar a la población afectada.

d. Mediante el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), se coordinó la respuesta sectorial frente a los hallazgos y eventos asociados a vectores del género Aedes en distintas regiones del país, en un contexto de riesgo creciente de introducción, dispersión y transmisión de enfermedades arbovirales. La respuesta ha incluido el fortalecimiento de la vigilancia vectorial, acciones de control de focos (peri-focos), inspecciones domiciliarias, desinsectación y búsqueda activa de casos.

e. En septiembre de 2025, con apoyo técnico de la OPS, Chile se convirtió en el primer país de las Américas en completar un análisis nacional del panorama de inteligencia epidémica. Este proceso permitió identificar actores, capacidades, brechas y prioridades, y sentó las bases para la elaboración del Plan Nacional de Inteligencia Epidémica, alineado con la Estrategia Regional de Inteligencia Epidémica 2024-2029 de la OPS.

f. Desde marzo de 2026, mediante el Sistema de Comando de Incidentes, la DES ha coordinado la respuesta sectorial frente a hallazgos y eventos asociados a vectores del género *Aedes* en Arica y Parinacota, Atacama, Antofagasta, Valparaíso —incluida Rapa Nui— y la Región Metropolitana. Las acciones han incluido vigilancia vectorial y epidemiológica, control de focos y perifocos, inspecciones domiciliarias, desinsectación, búsqueda activa de casos y vigilancia centinela de cuadros febriles sin foco. Además, se desplegaron tres equipos FETP

a Rapa Nui para investigar el brote de dengue por DENV-1 y se realizaron tres despliegues de apoyo a la Región de Antofagasta.

16. Derechos Humanos y Género

Se destaca la elaboración del primer Protocolo de Constatación de Lesiones con enfoque de derechos humanos, así como la participación en la construcción del Protocolo Intersectorial de Muertes bajo Custodia, Control o Cuidado del Estado.

Se fortaleció la articulación intersectorial mediante la participación en instancias como el Grupo Técnico contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Mesa Intersectorial de Trata de Personas, junto con el fortalecimiento de la red nacional de referentes en esta materia a través de procesos de capacitación en los Servicios de Salud y SEREMI de Salud.

17. Participación Ciudadana

El Ministerio de Salud promueve de manera permanente la participación ciudadana a través de diversos mecanismos, tanto obligatorios como voluntarios. Entre los primeros se encuentran los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), los Consejos Asesores Regionales y las Cuentas Públicas Participativas; mientras que entre los mecanismos voluntarios destacan las Escuelas de Líderes Sociales en Salud, los conversatorios y otras instancias de diálogo y vinculación con la comunidad.

Estos mecanismos son implementados por las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales, tanto en el nivel central como en las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, los Servicios de Salud y los establecimientos que integran la red asistencial del país.

En el nivel central, el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Salud ha mantenido un funcionamiento regular, contando con representantes de todas las regiones del país. Durante el año 2025, esta instancia sesionó en tres oportunidades, contribuyendo al fortalecimiento de la participación y la incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas de salud.

A continuación, se presenta el número de mecanismos de participación implementados y la cantidad de participantes registrados, desagregados por subsecretaría y tipo de mecanismo:

a. Subsecretaría de Salud Pública:

Mecanismo	**N° actividades realizadas**	**Temática** tratada	**N° participantes**
Cuenta pública participativa	16	Cuenta pública Gestión 2024	440
Consejo Asesor Regional	16	Todas las regiones programan a lo menos 3 reuniones anuales	3
Escuela de Líderes/Gestores Sociales	12	Calidad del Aire, Lideres en salud pública, Prevención en violencia de género, oferta pública de protección social	294
Conversatorios	8	Salud Mental, Estimulación infantil, Mes del Corazón	253

b. Subsecretaría Redes Asistenciales:

Mecanismo	N° actividades realizadas	Temática	N° participantes
Cuentas públicas participativas	29	Cuenta pública Gestión 2024	
Consejos consultivos y otras instancias de participación		Encuentros con la sociedad civil CIRA y CTT, evaluación comunidad usuaria	220
Grupos, Comités y mesas de trabajo		Mesas territoriales integración de la red asistencial (CIRA y CTT) en los Servicios de salud.	131
Diálogos y consultas ciudadanas	5 1	Encuentros con la sociedad civil Medición de satisfacción usuaria	803 25.099
Cabildos ciudadanos territoriales y sectoriales	1 1 3	II Congreso de Participación Social y Experiencia Usuaria 3 y 4 de abril 2025 Congreso Regional de Participación Social. Macro región sur. Encuentros de diálogo para la reforma en atención salud	400 160 250

18. Seguridad

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las y los trabajadores de la salud y asegurar la continuidad de la atención, el Ministerio de Salud implementó una estrategia nacional de prevención y abordaje de la violencia externa en los establecimientos de salud. Esta estrategia se basa en la coordinación intersectorial con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, municipios y otros organismos del Estado, fortaleciendo la gobernanza a través de Mesas de Seguridad en los 29 Servicios de Salud y una Mesa Estratégica Nacional.

Durante el período se implementó una metodología nacional para clasificar el nivel de criticidad de los establecimientos de salud, pasando de 127 establecimientos priorizados en 2025 a una categorización de 1.233 establecimientos para su implementación durante 2026, permitiendo focalizar las medidas de prevención y la coordinación con las policías según el nivel de riesgo.

Asimismo, se puso en marcha una nueva Plataforma de Registro de Agresiones, que fortalece la trazabilidad de los casos, incorpora alertas para agresiones de mayor gravedad y permite el seguimiento de los procesos judiciales asociados. Para su implementación se capacitó a los referentes de seguridad de los Servicios de Salud y a miles de funcionarios de la red asistencial.

En materia de prevención, se financiaron proyectos de seguridad en establecimientos de salud, incorporando infraestructura y equipamiento como sistemas de videovigilancia, botones de pánico, iluminación y cierres perimetrales. Entre 2025 y 2026 estas inversiones beneficiaron a más de 200 establecimientos de salud del país. Adicionalmente, se fortalecieron las capacidades institucionales mediante protocolos de actuación, criterios de diseño de espacios seguros, formación especializada de referentes de seguridad y campañas nacionales de sensibilización para promover el respeto hacia los equipos de salud.

19. Fondo Nacional de Salud (Fonasa)

Fonasa focalizó sus esfuerzos en aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud, mejorando simultáneamente la eficiencia del gasto y la calidad del servicio.

a. Sistema de acceso priorizado SAP

En julio de 2025 se puso en marcha el SAP, creado en el marco de la Ley N°21.736 publicada en abril de ese año, con el objetivo de abordar uno de los principales nudos críticos del sistema: las listas de espera quirúrgicas.

Previo a su implementación, existían tiempos de espera superiores a 600 días en cirugías de alto impacto, como las de endoprótesis de cadera y rodilla, con consecuencias sanitarias, sociales y económicas relevantes. Por tanto, la gestión de Fonasa no fue únicamente aumentar recursos, sino gestionar estratégicamente la capacidad instalada del sistema, articulando prestadores públicos y privados, incorporando tecnología y estableciendo mecanismos de priorización sanitaria.

Como resultado, se realizaron cinco mil 85 cirugías en seis meses, superando la meta de cuatro mil cirugías, en el marco de un presupuesto de 28 mil millones de pesos. Para el primer semestre de 2026, se proyecta la realización de cinco mil 293 cirugías, con un presupuesto de 35 mil 353 millones 62 pesos.

b. Hemodiálisis

La principal compra estratégica que realiza Fonasa es la hemodiálisis que garantiza el acceso con cobertura GES a más de 23 mil personas. En este contexto, se implementó un nuevo modelo de gestión de diálisis que cambia la asignación de cupos, pasando de un enfoque centrado principalmente en el precio a uno que incorpora calidad clínica, cercanía territorial y bienestar del paciente.

Los resultados muestran un impacto directo en la vida de las personas: se han optimizado seis mil 528 derivaciones, priorizando los centros más cercanos al domicilio, lo que reduce significativamente las distancias de traslado, mejorando la calidad de vida de las personas. Este cambio avanza desde un modelo transaccional a uno centrado en la calidad, con impactos concretos en adherencia a tratamiento y bienestar.

Para el primer semestre de 2026, se avanzó en la medición de indicadores de calidad de los centros de diálisis mediante la implementación de un ranking que evalúa periódicamente el estándar de calidad y reclasifica los prestadores. Estas acciones se apoyan en plataformas interoperables que permiten gestionar la demanda en línea, asignar prestaciones de forma automatizada y asegurar la trazabilidad de los procesos, fortaleciendo la transparencia y la toma de decisiones basada en datos.

c. Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos (TPH): esta importante estrategia de colaboración y complementariedad público-privada se fundamentó en la necesidad de resguardar el acceso oportuno a esta prestación de alta complejidad y riesgo vital. El financiamiento se estructuró bajo un modelo combinado de pago por Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD). El año 2025 se realizaron por esta vía 321 trasplantes de progenitores hematopoyéticos, lográndose por primera vez eliminar la lista de espera para esta línea de atención.

d. Grupos Relacionados por el Diagnóstico en Chile: El proceso de consolidación del modelo proyecta la incorporación de la mayoría de los establecimientos de mediana y alta complejidad al año 2026, alcanzando una cobertura estimada del 93 por ciento de los hospitales públicos (80 de 86 establecimientos) con el sistema plenamente operativo. Para este año 2026, el presupuesto considera 336 mil 820 millones de pesos una de las mayores expansiones presupuestarias.

20. Instituto de Salud Pública (ISP)

El ISP, como autoridad reguladora, garantiza que medicamentos, cosméticos, estupefacientes, psicotrópicos, dispositivos médicos, plaguicidas-pesticidas y elementos de protección personal que se fabrican, importan y distribuyen en el país cumplan con altos estándares de calidad, seguridad y eficacia.

a. Registro, Fiscalización y Vigilancia y ensayos Clínicos y Dispositivos Médicos

- En el año 2025, se certificaron 204 medicamentos bioequivalentes acumulando cinco mil 563 registros y 101 medicamentos nuevos; se inició reliance (confianza regulatoria) para acelerar el registro sanitario.
- En fiscalización, hubo mil 152 inspecciones a farmacias, droguerías, depósitos, recetarios magistrales, laboratorios farmacéuticos de control de calidad y acondicionadores, laboratorios cosméticos y centros de investigación clínica.
- Se autorizaron 52 nuevos establecimientos: laboratorios farmacéuticos, droguerías, bodegas, depósitos.
- Farmacovigilancia, emitió 39 alertas de retiro de medicamentos, 58 por ciento inyectables de uso hospitalario, instruyendo sumarios sanitarios.
- Se autorizaron 146 ensayos clínicos: 41 por ciento oncologías, 22 por ciento inmunologías, doce por ciento broncopulmonares.
- El ISP impartió 27 capacitaciones de farmacovigilancia, a tres mil 845 personas. Adicionalmente, se fortaleció la colaboración entre el ISP y los Servicios de Salud, desarrollando actividades de capacitación en ocho Servicios, capacitando a 458 profesionales de la salud pertenecientes a la red asistencial pública.

b. Vigilancia y Referencia del Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia (LBMR)

En 2025, los laboratorios del ISP confirmaron casos de diversas enfermedades infecciosas:

- Dengue: 506 muestras 49 casos confirmados, sin casos en Isla de Pascua, todos importados.
- Hantavirus: 687 muestras analizadas y 44 casos confirmados el año 2025, lo que representa un aumento del 29,4 por ciento respecto de los casos confirmados el año 2024 (34).
- Neisseria meningitidis (meningococo): 99 casos 16,4 por ciento. más a lo observado el año 2024.
- Streptococcus pyogenes: se confirmaron 658 casos, una disminución del 9,1 por ciento respecto del 2024.
- Pesquisa VIH: nueve mil 422 muestras analizadas, que representan un aumento del 3,8 por ciento respecto del 2024 y cuatro mil 313 casos fueron confirmados, con un tiempo de respuesta promedio de seis días hábiles, entre la recepción de la muestra en el ISP hasta la entrega del informe.
- Programa Trasplante: un total de 36 mil 631 exámenes lo que representa un aumento del 8,8 por ciento respecto del total de exámenes realizado el año 2024. Se realizaron 262 estudios para órganos en donantes cadavéricos y vivos. Destacan los trasplantes de riñón (392), hígado (184), corazón (50) y pulmón (44), algunos con más de un órgano por procedimiento.

c. Vigilancia y Referencia Ambiental y Alimentaria

En el año 2025, se realizó un total de 18 mil 269 ensayos ambientales, incrementando los análisis de fisicoquímica y microbiológico de aguas, de dos mil 472 en 2024 a doce mil 819 en 2025. Esto se traduce en un incremento de 358 por ciento en el total de análisis efectuados por el departamento.

En alimentos, los análisis de residuos de plaguicidas y de medicamentos veterinarios aumentaron de 36 análisis en 2024 a tres mil 875 en 2025. Se dio respuesta frente a alertas por Hepatitis A en muestras de agua y alimentos en las regiones de Ñuble y Biobío y se participó en los estudios de detección de Legionella spp en muestras de aguas en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y Araucanía.

d. Supervisiones

Durante 2025 se realizaron 36 supervisiones a laboratorios clínicos y bancos de sangre y 80 Fiscalizaciones. En materia de salud ocupacional se realizaron doce programas de evaluación a centros audiométricos, y trece a centros que realizan prestaciones relacionadas a la silicosis.

El ISP organiza el Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) que actualmente incluye las áreas de: Bacteriología, Hematología, Inmunohematología, Inmunología, Parasitología, Química Clínica, Virología y Citodiagnóstico, con 42 subprogramas disponibles.

21. Central de Abastecimiento (Cenabast)

a. Principales hitos y acciones

- Se aumentó la participación de intermediación de fármacos para la red asistencial, cercano al 80 por ciento del total de las compras, generando un ahorro superior a los 600 millones de pesos para el Estado.

- Se inició la implementación del proyecto de interoperabilidad con las bodegas de los Hospitales, para mejorar la eficiencia en el proceso de abastecimiento de fármacos e insumos médicos para la red asistencial.

- Se incrementó el número de farmacias adheridas a la Ley Cenabast, alcanzando más de mil 300 a lo largo de todo el País, así como del total de cajas vendidas.

- El número de farmacias comunales que se abastecen a través de Cenabast aumenta a más de 170 lo que ha permitido traspasar los menores precios de los fármacos directamente a la población.

- Se Incorporaron nuevos productos y fármacos a la canasta de intermediación, como por ejemplo los denominados radio fármacos, para el tratamiento del cáncer de tiroides.

- Se inició un proceso para obtener registro sanitario propio para importar directamente ciertos medicamentos y productos críticos. Esta medida resuelve problemas de stock y altos costos en productos que presentan pocas opciones de compra, asegurando el abastecimiento de la red pública y farmacias.

- Implementación del beneficio de la comisión cero por ciento, para la Atención Primaria de Salud que se abastece a través de Cenabast. A contar de marzo del 2026 Cenabast ya no cobra comisión del siete por ciento a los Municipios por su rol de intermediación en las compras de fármacos e insumos, con el consiguiente beneficio para los presupuestos de los Gobiernos locales.

22. Superintendencia de Salud

a. Doble techo, doble protección: En aplicación de la Ley N° 21.674, conocida como "Ley Corta de Isapres", la Superintendencia de Salud limitó los ajustes de precio de las isapres en el proceso de Adecuación de Precio Base (APB) 2026. La norma establece que los cambios en el precio base se regirán por dos límites que operan de manera simultánea y tienen por objetivo resguardar a las personas afiliadas:

- El primer límite corresponde al Indicador de Costos de la Salud (ICSA). En marzo de 2026, la Superintendencia publicó el tope máximo de 3,5 por ciento que las isapres pueden aplicar en la adecuación de sus precios base, porcentaje que no puede ser excedido por dichas instituciones.

- El segundo límite corresponde a la verificación individual. En este caso, cada isapre debe acreditar ante la Superintendencia de Salud que sus costos respaldan el porcentaje de adecuación que pretenden aplicar. Si una isapre no logra demostrarlo, solo podrá aplicar un ajuste equivalente a los costos efectivamente verificados ante la Superintendencia. En caso de que dichos costos superen el 3,5 por ciento, se mantiene igualmente el tope máximo establecido por el ICSA.

b. Fortalecimiento de la fiscalización

- Primera verificación de Prima GES: En 2025, en ejercicio de una nueva facultad legal, la Superintendencia de Salud realizó por primera vez la verificación de las primas GES que las isapres pretendían aplicar a su cartera de afiliados. Esta revisión permitió ajustar los montos informados por las aseguradoras que no cumplieron los criterios establecidos. Como resultado, tres isapres debieron aplicar una prima inferior a la originalmente informada. Este proceso abarcó a aproximadamente 2,6 millones de personas afiliadas.

- Primera fiscalización de la prestación GES N°86 (Atención integral de salud en agresión sexual aguda): El objetivo fue identificar incumplimientos de las garantías y emitir instrucciones para su corrección y la caracterización de los grupos afectados según edad, sexo, género y situación de discapacidad.

c. Ampliación de derechos mediante circulares

- Se instruyó a las isapres otorgar cobertura a cirugías plásticas sin fines estéticos que cuenten con diagnóstico y orden o indicación médica. Asimismo, se estableció que los rechazos de bonificación por considerar que alguna prestación de salud tiene fines estéticos deben estar debidamente fundamentados (Intendencia de Fondos (IF) N°503, julio de 2025).

- Se amplió la cobertura de consultas con nutricionista. Anteriormente, esta cobertura aplicaba solo en casos de sobrepeso u obesidad determinados por el IMC; actualmente, incluye cualquier trastorno alimentario presente en las personas afiliadas (IF N°508, septiembre de 2025).

d. Fortalecer los niveles de calidad y seguridad asistencial.

- Ampliación de especialidades en el Registro de Prestadores Individuales de Salud (RNPI) con la incorporación de diez nuevas especialidades de la medicina, una de la odontología y por primera vez una especialidad de la enfermería. Al 31 de diciembre de 2025 se registraron 969 mil 918 profesionales inscritos en Registro de Prestadores Individuales de Salud de un millón 100 mil profesionales que solicitaron certificados de inscripción en el RNPI.

III. PLAN DE ACCIÓN MINISTERIAL 2026-2030

1. Programación 1 junio 2026 – 1 junio 2027

a. Plan de acción 90 días

- Se elaborará un protocolo para conectar a los pacientes que tienen cánceres con garantías incumplidas con su prestador para inicio de Diagnóstico, Tratamiento o Seguimiento, según corresponda.

- Elaboración del protocolo del flujo del paciente que determine el viaje desde el contacto inicial hasta el que el paciente comienza su proceso de Diagnóstico, Tratamiento o Seguimiento. Se creará de la Oficina de Inteligencia Sanitaria.

- Debido a la fragmentación histórica de los datos sanitarios, sin una fuente única que permitiera la toma de decisiones ágiles, el Ministerio de Salud avanzó en la creación y formalización de la Oficina de Inteligencia de Datos. Esta será un nodo integrador oficial de la información institucional, consolidando flujos de información, definiendo estándares y responsables por fuente. En el marco del Plan de 90 días, este equipo asumirá la consolidación de la información de listas de espera oncológicas y la visualización actualizada del estado de las prestaciones, el gasto ejecutado y el avance por Servicio de Salud, sentando las bases para una gestión sanitaria eficiente, trazable y permanente.

- Se lanzará la estrategia segundo prestador automático al vencerse la garantía de oportunidad en Casos de Cáncer.

- Sistema que permita que, al vencerse la garantía de oportunidad de los casos de Cáncer GES, se emita la orden a segundo prestador en forma automática. Acá se debe trabajar con la Superintendencia y Fonasa para resolver. Se creará de un programa de resolución fast para cirugías No GES y No Cáncer.

- Pacientes sobre percentil 90 de espera serán derivados a resolución, utilizando los diferentes mecanismos de compra existentes.

- Lanzar las auditorias necesarias de acuerdo con hallazgos de la entrega.

- Cada Servicio de Salud, Fonasa y Gabinete solicitará aquellas que les parezcan relevantes de acuerdo a los hallazgos de las entregas.

- Se resolverán por telemedicina las listas de espera de APS con Hospital digital para Hipertensión Arterial y Diabetes.

- Elaboración de protocolo de derivación fast a Hospital Digital desde APS, pacientes en espera de derivación de APS a atención secundaria sobre percentil 75, por Hipertensión Arterial y Diabetes.

- Se elaborará un convenio tripartito que permita mejorar la tramitación de licencias médicas en especial en los casos de cáncer.

- Mejora continua de la plataforma milicenciamedica.cl para aumentar la capacidad de ingreso de documentos y consulta de estados de trámite. Paso a producción y a funcionamiento de plataformas digitales y sistemas que permitan un trabajo más eficiente tanto en los tiempos de tramitación como en el control de gestión a lo largo de las Compin del país. Reestructuración interna del Departamento Compin Nacional, la cual potenciará el control de gestión, el desarrollo de sistemas y uso de tecnologías digitales en los procesos, así como también potenciar y crear la Unidad de Fiscalización para pesquisar oportunamente licencias fraudulentas y hacer seguimiento de estas. Se mejorará el control de licencias médicas.

- Implementación de un sistema de reporte periódico de fiscalización y consolidación de la nueva Unidad de Fiscalización con indicadores de seguimiento centralizado. Lograr avance en la gestión de trámites de usuarios oncológicos y usuarias con licencias maternales que requieren resolución prioritaria. Se lanzará trabajo intersectorial: para implementar la estrategia nacional de prevención en salud.

- Institucionalizar mesa de trabajo intersectorial entre Deportes, Educación, Desarrollo Social, Vivienda y Medio Ambiente mediante resolución, con el fin de avanzar en los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Salud 2030.

- Se participará activamente en la implementación en la Ley Integral de Personas Mayores, actualmente en discusión.

- La implementación contará con la participación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Asociación de Municipalidades y el Ministerio de Educación.

- Se modificará el Reglamento N° 283, ampliando la resolutividad de los centros de la red asistencial.

- Esto permitirá que los niveles primarios y secundario puedan hacer prestaciones que le son de exclusiva responsabilidad del Nivel terciario.

- Se cerrarán el 100 por ciento de los sumarios asociados a informe de la contraloría LM y Viajes en el sector salud

- Formalización de las modificaciones a los decretos supremos N°3 que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas, N°7 que aprueba el Reglamento sobre las guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas y el Decreto N°47 que aprueba el reglamento para la calificación y certificación de la discapacidad, con el objetivo de modernizar el sistema. Se creará la Unidad de Fiscalización en el Departamento de Compin Nacional la cual estará encargada de hacer seguimiento a las fiscalizaciones y las sanciones ante el hallazgo de mal uso de licencias médicas.

b. Instituciones Autónomas

- Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast)

- Aumentar la participación en la intermediación de fármacos, insumos y dispositivos médicos para la red asistencial, priorizando la atención primaria de salud, con el objetivo de generar ahorros para el sistema.

- Priorizar el abastecimiento de fármacos asociados a las enfermedades oncológicas, en coherencia con el decreto de alerta impulsado por Minsal.

- Contribuir a mejorar la eficiencia en la gestión del stock de fármacos en la red hospitalaria, mediante la implementación de un proyecto de interoperabilidad orientado a establecer un sistema de reposición automática, que permita reducir vencimientos, mermas y sobre stock de medicamentos, evitando la pérdida de recursos. El foco prioritario estará en la implementación de esta iniciativa en los 40 hospitales de mayor tamaño de la red.

- Fortalecer la implementación de la Ley Cenabast, con el objetivo de traspasar a la población los ahorros derivados de la compra centralizada y la agregación de demanda de medicamentos. Para ello, se promoverá la incorporación de nuevas farmacias privadas adheridas, la ampliación de la canasta de fármacos disponibles bajo criterios sanitarios y generación de ahorro, así como potenciar la difusión de sus beneficios a través del sitio web www.remediosmasbaratos.cl.

- Impulsar iniciativas orientadas a mejorar la distribución de fármacos para la población, con especial énfasis en adultos mayores y pacientes crónicos, mediante el fortalecimiento de mecanismos como el despacho a domicilio y el canal de farmacias comunales.

• Fondo Nacional de Salud (Fonasa)

- Reducción Lista de Espera Oncológica: Gestionar, con prestadores públicos y privados el otorgamiento de las prestaciones a las -33 mil personas en listas de espera oncológicas No GES y garantías de oportunidad oncológicas GES retrasadas.

- Reducción Histórica de Listas de Espera: Enfrentar el atochamiento en la red pública con más de 3,1 millones en espera de consulta de especialista, focalizándose su resolución según la priorización que realice el Ministerio de Salud.

- Sostenibilidad Financiera y Equilibrio Presupuestario: Lograr un equilibrio financiero buscando que cada peso invertido contribuya a años de vida saludable, mediante un uso más eficiente de los recursos en un contexto de consolidación fiscal, donde el gasto sanitario sigue siendo alto.

- Mejorar la Gestión del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL): Impulsar propuestas que aseguren el uso adecuado y control de este beneficio.

- Gestión del Sistema de Acceso Priorizado (SAP) 2026: Dar continuidad al SAP para cirugías priorizadas (rodilla, cadera, entre otras) en pacientes en lista de espera quirúrgica, con copago cero y foco en personas de menores ingresos.

- Modernización y Transformación Digital: Avanzar en la digitalización y el uso de inteligencia artificial para el seguimiento de pacientes y la gestión de la información, conforme a la Estrategia de Datos del Estado.

- Compra eficiente de servicios a través de GRD en la red pública: Mantener como prioridad el trabajo colaborativo con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con el fin de fortalecer la eficiencia en la adquisición de servicios.

c. Adultos Mayores

• Se implementarán acciones clave para dar cumplimiento al Artículo N°9 del proyecto de ley integral, el cual garantiza el derecho a la salud física y mental sin discriminación, promueve la prevención temprana y asegura atención preferente, conforme a la Ley N°20.584. Estas acciones incluyen:

• Incorporación de un enfoque preventivo y predictivo de fragilidad a lo largo del curso de vida mediante la reformulación del Examen de Medicina Preventiva del Adulto (Empa).

• Planificar y ejecutar capacitaciones a los equipos interdisciplinarios de atención de salud en los niveles secundario y terciario en el reconocimiento, evaluación y manejo de los problemas asociados al envejecimiento, con énfasis en la identificación y prevención de la fragilidad y la dependencia funcional.

• Monitorear el cumplimiento de la Ley N° 21.168 y Ley N°21.380 en los centros de salud.

• Realizar encuentros intergeneracionales entre jóvenes y personas mayores. Estos espacios son puntos estratégicos de participación, en los que las personas mayores se vinculan activamente con jóvenes, familias y organizaciones locales. Convirtiéndose en herramientas efectivas para combatir el edadismo en nuestra sociedad.

d. Otras Prioridades

- Tabaco

- Combate al Comercio Ilícito de Tabaco: Chile se encuentra en la fase final de adhesión al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, lo que permitirá fortalecer las capacidades de rastreo y control fronterizo. Actualmente, se avanza en la coordinación técnica con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia para armonizar la legislación nacional con el protocolo, especialmente en materias de extradición y tipificación de delitos transnacionales, con el fin de facilitar la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de tabaco.

- Desarrollo de advertencias sanitarias: En cumplimiento de la obligación legal de actualizar las advertencias sanitarias para el periodo 2027–2029, se encuentra en desarrollo un proceso de licitación orientado a seleccionar las imágenes más efectivas, mediante estudios con grupos focales.

- Propuestas de modificaciones legales: Tramitación del proyecto de ley incorporado en el boletín 8886-11 que establece el empaquetado genérico de productos de tabaco, la prohibición de aditivos saborizantes y aromatizantes y la prohibición de exhibición de productos de tabaco.

- Desarrollo de reglamentos asociado a Ley N°21.642: Limitación de publicidad para SEAN/SESN, líquidos de vapeo e incorporación de advertencia sanitaria para publicidad de productos. Este Decreto afecto N°28 busca establecer una restricción de publicidad solo a medios impresos y radiales en horario de protección a menores de edad incorporando una advertencia sanitaria impresa y auditiva para medio de seis segundos.

  Decreto limitación y prohibición de aditivos para SEAN, SESN y líquidos de vapeo, que busca por primera vez en base al artículo nueve de la Ley N°19.410 establecer prohibiciones y limitaciones asociadas a adicción, daño y riesgo para la salud de las personas. Documento se encuentra en evaluación jurídica y a la espera de poder continuar con su trámite.

- GES 90 diseño e implementación de capacitaciones

  En licitación para generar un curso de capacitación para profesionales de salud primaria que pueda ser replicado y disponible en línea con acreditación. Esto debido a que en la canasta GES no fue posible incorporar la formación de profesionales lo que resulta relevante para el cumplimiento de los objetivos.

- Prevención y control del consumo de alcohol

- Durante el año 2026 se proyecta un incremento de entre un 20 y un 30 por ciento en la producción de vigilancia de la publicidad de bebidas alcohólicas en todas las plataformas de transmisión, considerando la entrada en vigor de nuevas restricciones, tales como la prohibición de publicidad dirigida a menores de edad, su asociación a actividades deportivas y las limitaciones de emisión en televisión abierta y radio, entre otras. Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se prevé iniciar la implementación de medidas de protección sanitaria conferidas por la ley y priorizadas por el Ministerio de Salud orientadas a enfrentar el consumo nocivo de alcohol, con énfasis en el fortalecimiento de la vigilancia y fiscalización de la normativa.

- Para el año 2027, se espera que, tras la completa entrada en vigor del reglamento, la población y especialmente los menores de edad, disponga de entornos más saludables, que no promuevan directa ni indirectamente el consumo de bebidas alcohólicas a través de la publicidad, en complementariedad con otras regulaciones que restringen su expendio. De este modo, se proyecta contribuir a la reducción del consumo temprano de alcohol en adolescentes y jóvenes y, de forma indirecta, a disminuir la prevalencia de consumo nocivo en la población adulta.

- Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual

El año 2026 se espera avanzar en los siguientes hitos:

- Implementar un sistema estandarizado de control de stock para la gestión nacional de insumos, tales como: preservativos, lubricantes, autotest y test visuales.

- Lanzar y difundir la Norma de Prevención de la Transmisión Vertical del VIH y la Sífilis, durante el segundo semestre 2026.

- Iniciar la implementación de PrEP en dos regiones faltantes, durante el primer semestre 2027.

- Iniciar la implementación de protocolos de profilaxis postexposición al VIH-PEP y el protocolo para la profilaxis postexposición a las ITS bacterianas-DoxyPep, durante el primer semestre de 2027.

- Estrategia Nacional para detener la aceleración del sobrepeso y obesidad en Niñas, Niños y adolescentes

Se proyecta la consolidación, profundización y ampliación de las políticas públicas en regulación alimentaria y nutrición, configurando un desafío estratégico de alta complejidad técnica, operativa y regulatoria. En este contexto, uno de los ejes prioritarios será el fortalecimiento del marco regulatorio en nutrición y alimentos, a través del desarrollo de procesos simultáneos que incluyen la elaboración de nuevos decretos, la actualización de directrices técnicas, la implementación de ajustes al sistema de etiquetado de alimentos y el apoyo técnico a proyectos de ley en tramitación. En particular, se avanzará en materias clave como:

- Regulación de la publicidad de alimentos y bebidas alcohólicas.

- Profundización de las medidas aplicables a productos con sellos “ALTO EN”.

- Revisión del uso de edulcorantes no calóricos.

- Promoción del acceso al agua en establecimientos de expendio de alimentos.

- Regulación de alimentos preparados en cadenas de comida rápida y la adopción del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

En el ámbito de los Programas Alimentarios, implicará un trabajo de mejora de gestión que permitirán mantener operatividad y entrega de alimentos reformulados nutricionalmente, y que en general contribuyen a la seguridad alimentaria de la población beneficiada, pero, además, constituyen parte del tratamiento dietético para determinadas enfermedades.

En paralelo, se avanzará en la implementación de nuevas líneas de acción, como la vigilancia de alimentos libres de gluten y la fortificación con vitamina D en leches y harinas, contribuyendo a mejorar la calidad nutricional de la oferta alimentaria y a responder a necesidades específicas de la población.

2. Programación 2026-2030:

1) Fortalecimiento de la gobernanza para las transformaciones del sistema de salud

Con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado para planificar y conducir las transformaciones del sistema público de salud con una mirada de largo plazo, durante 2026 el Ministerio de Salud impulsó la creación de nuevas instancias permanentes de gobernanza y asesoría estratégica.

En junio de 2026 se constituyó el Consejo Nacional de Salud, instancia asesora convocada por la Ministra de Salud e integrada por expertos provenientes del sector público, privado y académico. Su objetivo es aportar una

visión transversal y de Estado para enfrentar los principales desafíos sanitarios del país, mediante la elaboración de propuestas concretas en cuatro ámbitos prioritarios: el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud; la actualización de la Estrategia Nacional de Salud; la reducción de los tiempos de espera; y el desarrollo de criterios e indicadores para la priorización de la inversión en infraestructura sanitaria. El trabajo del Consejo se desarrolla a través de comités temáticos y cuenta con el apoyo técnico de una secretaría ejecutiva conformada por las divisiones del Ministerio de Salud.

De manera complementaria, en mayo de 2026 se constituyó el Consejo Asesor Estratégico y Consultivo de Fonasa, orientado a fortalecer la planificación estratégica del seguro público. Esta instancia asesora el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 2026–2030 de Fonasa, contribuyendo a fortalecer la planificación de largo plazo, la sostenibilidad y el desarrollo institucional del principal asegurador público del país.

La creación de ambos consejos representa un fortalecimiento de la gobernanza del sistema de salud, incorporando de manera permanente la experiencia técnica y la evidencia en la toma de decisiones, con el propósito de orientar las políticas públicas hacia las necesidades de la población y consolidar las transformaciones estratégicas proyectadas al año 2030.

2) Situación Financiera

Con el objetivo de implementar una estrategia que se haga cargo de la tensión financiera del sector y de la emergencia fiscal, se ha diseñado una estrategia de dos velocidades, una respuesta inmediata de contención y eficiencia del gasto 2026 y una reforma estructural del financiamiento sectorial para el mediano y largo plazo. Respecto a la respuesta inmediata, se proponen cuatro medidas de gestión, siendo la primera enfocada en la presión de gasto no prevista, ejecutando un catastro exhaustivo de compromisos y obligaciones de los Servicios de Salud y Fonasa que no tengan cobertura en la Ley de Presupuestos 2026. Esta priorización y revisión se realizará con Dipres. Una segunda medida vinculada al personal de los Servicios de Salud busca revisar y levantar la programación de horas médicas, identificando funciones duplicadas y reduciendo el ausentismo laboral con control en el uso de licencias médicas. Con esto se busca generar un aumento en la productividad, sin incurrir en costos adicionales.

En materia de adquisiciones, las compras se centralizarán a través de Cenabast, así como también las licitaciones conjuntas, con precios referenciales vinculantes para insumos críticos, se espera una reducción de costo en los insumos de alto volumen de entre el diez y quince por ciento. En línea con mejorar la eficiencia y mejorar la resolución de la lista de espera oncológica, se aumentará la producción asistencial pública en conjunto con la creación de convenios de resolución con el sector privado con aranceles GES de la canasta integral, el impacto esperado de esta gestión es cumplir con las garantías explicitas en más del 95 por ciento durante los primeros 90 días. A nivel legislativo se implementará una quinta medida, que busca identificar iniciativas legislativas con impacto fiscal no previsto, por lo que se revisarán proyectos relevantes en discusión parlamentaria, con el objetivo de recalcular su financiamiento debido a la estrechez financiera del sector y prevenir posibles compromisos presupuestarios que no se encuentren considerados en el presupuesto vigente.

La instauración de una nueva arquitectura de financiamiento del sector es la segunda estrategia de mediano a largo plazo. Esta reforma busca alinear los incentivos del sistema con la producción efectiva, para separar los componentes administrativos de los asistenciales y modernizar los mecanismos de asignación de recursos.

a. Plan de acción 2026-2030 – Líneas de acción más emblemáticas

El plan de acción de esta administración está centrado en otorgar una prestación de salud oportuna y de calidad a todas las personas, eliminando a la enfermedad como obstáculo para lograr el desarrollo personal y familiar. El objetivo es que la salud pública esté al servicio de los ciudadanos, con un sistema moderno y eficiente que facilite una prestación de calidad. Para conseguir este objetivo hay cuatro líneas de acción principales, que abordan los desafíos actuales del sistema de salud:

- Gobernanza de la red asistencial: para lograr realizar cambios en el sistema será necesario empoderar a sus líderes, lo que hoy es un desafío en la red.

- Serán priorizados los concursos de ADP para Servicios de Salud y hospitales, para favorecer una visión de largo plazo en la conducción de éstos.

- Serán eliminadas las trabas administrativas para contar con subdirecciones médicas con verdadero poder de decisión.

- La carga administrativa de los centros de salud será reducida, en especial la información solicitada desde el nivel central, a través de una consultoría especializada.

- La Estrategia Nacional de Salud será reformulada para que oriente la actividad clínica hacia objetivos sanitarios prioritarios con indicadores de resultado validados.

- Será creada una Estrategia Nacional de Prevención que aúne la prevención de cáncer, cardiovascular y de enfermedades de salud mental en APS.

- Modelo de acceso y tiempos de espera: la red asistencial deberá ser flexible, adaptarse a la diversidad del territorio nacional, y facilitar una atención oportuna y de calidad, sin tiempos de espera desproporcionados que impacten en el pronóstico y calidad de vida de los pacientes, especialmente en el ámbito oncológico.

- El tiempo de espera para consulta de nueva especialidad e intervenciones quirúrgicas será reducido.

- Las garantías GES vencidas serán reducidas.

- El segundo prestador GES automático será instaurado, para evitar traspasar la responsabilidad al paciente de los errores del sistema y agilizar la atención sanitaria.

- El repertorio de exámenes realizados en APS será ampliado para que ésta pueda ser más resolutiva.

- La presencia de especialistas en APS será potenciada por medio de concursos de especialidades médicas, poniéndose a su disposición más tecnologías e instrumental.

- El financiamiento de la APS será optimizado con un aumento del pago per cápita y disminuyendo la carga administrativa derivada del pago por programas.

- Las trabas administrativas a la resolutividad de los hospitales de primer nivel serán flexibilizadas.

- Será implementado un piloto de retiro de medicamentos en farmacias locales para pacientes que utilizan medicamentos crónicos.

- Disciplina fiscal y sanitaria: el sistema de salud presenta defectos de gestión y de uso de recursos que en último término repercuten en una peor atención para el ciudadano; será necesario potenciar el profesionalismo en la red y alinear los incentivos hacia una mayor eficiencia y probidad.

- Será diseñado un plan de inversiones que respete el marco presupuestario y responda a criterios sanitarios con lógica territorial.

- El financiamiento de los hospitales será reformulado, transitando desde el pago por criterios históricos a uno basado en la productividad.

- La convergencia fiscal de los programas ministeriales y los servicios de salud será lograda.

- Todos los sumarios asociados a las CIC de Contraloría serán cerrados, ejecutándose las sanciones correspondientes.

- El control de las licencias médicas fraudulentas será mejorado con fiscalización activa desde el nivel central, reduciéndose a cero las licencias aprobadas por incumplimiento de plazos de la COMPIN.

- El desabastecimiento y las mermas de medicamentos serán disminuidos a través de programas de compra conjunta entre hospitales, facilitada por Cenabast.

- La agregación de demanda en compra de insumos, medicamentos y vacunas será facilitada, para conseguir precios más competitivos.

- Transformación digital en salud: las tecnologías de la información podrán ser utilizadas para acercar la atención a las personas, especialmente en contextos de ruralidad; para reducir la carga administrativa, y para contar con mejores datos que orienten la actividad asistencial.

- Será creado un protocolo fast de derivación a través de Hospital Digital para los pacientes con enfermedades crónicas.

- Serán implementados sistemas de inteligencia artificial para la evaluación de los fondos de ojo, la prestación con más garantías GES incumplidas a nivel nacional.

- Será alcanzada la interoperabilidad total entre sistemas de la red de salud.

- La extracción de información de las fichas clínicas será automatizada, disminuyendo la carga administrativa asociada a la construcción de indicadores.

- El área de datos y estadística del ministerio será modernizada, para contar con información en tiempo real sobre listas de espera y objetivos sanitarios.

- La interoperabilidad de los sistemas de las bodegas de los hospitales, en especial los de alta complejidad, será lograda para alcanzar un abastecimiento más eficiente y abaratar costos de compra de medicamentos.